BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BLOC DE COMPÉTENCES 3 · STAGE DE SANTÉ PUBLIQUE

Toutes les connaissances pour le stage de santé publique

Le cours de référence du stage BC3 et de l'épreuve E5, pour partir en stage même en débutant

Cadre du stage et de l'épreuve E5

Santé publique, politiques et acteurs (PNNS 5, SNANC, PNA 4)

Démarche de projet en 6 étapes, avec tous les outils

Communication, animation, ateliers culinaires

Épidémiologie, enquêtes, veille, éthique, RGPD, numérique

Le dossier E5 : règles officielles, plan, Word, PDF, diaporama, photos

Calculs vérifiés, modèles à recopier, glossaire

Ce que contient ce document

- Le stage dure 6 semaines dans la même structure, en deux périodes, et prépare l'épreuve E5 (coefficient 4)
- Un projet de santé publique suit 6 étapes : analyser, prioriser, concevoir, réaliser, évaluer, valoriser
- Chaque chiffre que vous citez doit être sourcé et daté ; chaque calcul doit être refait
- En 2026, les références sont le PNNS 5 (2026-2030), la SNANC 2025-2030 et le PNA 4
- L'éthique (consentement, RGPD, droit à l'image) s'applique à chaque étape, dès le premier jour
- Le dossier écrit fait 10 pages maximum hors annexes ; sans dépôt dans les délais ni attestations de stage, pas d'épreuve E5

Version du 26 octobre 2026 · sources consultées entre octobre 2025 et octobre 2026 · à compléter avec le Guide du stage jour par jour

Sommaire

Mode d'emploi de ce cours 4

Partie 1 – Le cadre : stage, épreuve E5, compétences 5

1.1 Le stage d'interventions en santé publique 5
1.2 L'épreuve E5 7
1.3 Les six compétences du bloc 3 7
1.4 Les compétences psychosociales 8

Partie 2 – Les bases de la santé publique 9

2.1 Santé, santé publique, promotion de la santé 9
2.2 Les déterminants de la santé 10
2.3 Les niveaux de prévention 12
2.4 Les indicateurs de santé et les calculs de base 13

Partie 3 – Politiques publiques, acteurs et sources de données 15

3.1 Les plans nationaux en vigueur au 26 octobre 2026 15
3.2 Les lois qui comptent pour un projet en nutrition 16
3.3 Qui fait quoi : les acteurs 17
3.4 Où trouver les données pour le diagnostic 18

Partie 4 – Comprendre le public 19

4.1 Pourquoi les gens mangent ce qu'ils mangent 19
4.2 Le changement de comportement : le modèle de Prochaska et DiClemente 19
4.3 Quelques notions de psychologie sociale 20
4.4 La littératie en santé 20
4.5 Les publics du stage : points d'attention 21

Partie 5 – Éthique, droit et numérique 22

5.1 Les principes éthiques de l'intervention 22
5.2 Le secret professionnel et la discrétion 22
5.3 Le RGPD appliqué au stage 22
5.4 Le droit à l'image 23
5.5 L'environnement numérique sécurisé (C3.6) 23

Partie 6 – La démarche de projet en santé publique, étape par étape 25

6.1 Vue d'ensemble 25
6.2 Étape 1 : l'analyse de la situation (le diagnostic) 26
6.3 Étape 2 : choisir les priorités et fixer les objectifs 27
6.4 Étape 3 : concevoir le projet 29
6.5 Étape 4 : la mise en œuvre 31
6.6 Étape 5 : l'évaluation 32
6.7 Étape 6 : la valorisation et la capitalisation 33

Partie 7 – Communiquer et animer (C3.5) 34

7.1 Le schéma de la communication 34
7.2 Les techniques d'écoute active 34
7.3 Animer un groupe 34
7.4 Concevoir un support 35
7.5 Communiquer avec les professionnels 36
7.6 Prendre la parole en public 36

Partie 8 – Les ateliers culinaires (C3.2) 37

8.1 Pourquoi un atelier culinaire 37
8.2 Concevoir l'atelier : la fiche atelier 37
8.3 La fiche technique et le calcul du coût 37
8.4 L'analyse nutritionnelle d'une recette 38

8.5 Ce qui se passe dans la casserole : les transformations physico-chimiques 39
8.6 Adapter l'atelier 39
8.7 Hygiène et sécurité en atelier 40
8.8 Analyse sensorielle et dégustation 41
8.9 Éco-gestes et alimentation durable 42
8.10 L'atelier de l'épreuve E5 (temps 2, 3 heures) 42

Partie 9 – Épidémiologie, enquêtes et traitement des données (C3.3) 43
9.1 Les types d'études 43
9.2 Mesurer une association 43
9.3 Le questionnaire 44
9.4 Les méthodes qualitatives 45
9.5 Les enquêtes alimentaires 46
9.6 Saisir, traiter et présenter les données 46
9.7 Lire et écrire un article : la structure IMRAD 47

Partie 10 – Veille et recherche documentaire (C3.4) 48
10.1 Qu'est-ce que la veille ? 48
10.2 Organiser sa veille 48
10.3 Chercher efficacement 48
10.4 Évaluer la fiabilité d'une source 49
10.5 Citer ses sources 49

Partie 11 – Le dossier écrit E5 (le « mémoire »), le Word, le PDF, le diaporama et l'oral 50
11.1 Ce que disent les textes officiels, et ce qu'ils ne disent pas 50
11.2 Chaque jour de stage nourrit une partie du dossier 51
11.3 Le plan conseillé et le budget de pages 52
11.4 Les règles de rédaction 53
11.5 Les annexes 54
11.6 Faire le fichier Word pas à pas 55
11.7 Faire le PDF 56
11.8 Les photos et documents à rapporter de la structure 57
11.9 Le diaporama de soutenance (PowerPoint) 59
11.10 L'exposé de 10 minutes maximum 60
11.11 L'entretien de 20 minutes 60
11.12 L'auto-contrôle final avec les indicateurs du référentiel 61
11.13 Le calendrier du dossier, du stage au dépôt 62

Partie 12 – Boîte à outils : modèles et glossaire 63
12.1 Fiche identité de la structure 63
12.2 Grille d'observation 63
12.3 Guide d'entretien avec un professionnel 63
12.4 Journal de bord : la page du jour 63
12.5 Glossaire 64

Mode d'emploi de ce cours

Ce cours rassemble tout ce qu'il faut savoir pour réussir le stage de santé publique et l'épreuve E5. Il est écrit pour un étudiant qui part de zéro : chaque notion est définie, chaque outil est expliqué pas à pas, chaque calcul est détaillé.

Il complète le cours complet BC3 (21 chapitres) sans le remplacer. Le cours complet approfondit chaque compétence. Ce support-ci va droit à ce qui sert sur le terrain, dans l'ordre où vous en aurez besoin.

Méthode – Comment utiliser ce cours avec le guide jour par jour

1. Avant le stage, lisez les parties 1, 2 et 3 en entier (environ 4 heures).
2. Chaque soir de stage, le Guide du stage jour par jour vous dit quelles sections relire pour le lendemain (par exemple « relire 6.3 Arbre à problèmes »).
3. Pendant la rédaction du dossier, utilisez les parties 6, 9 et 11 : la partie 11 explique le plan, les règles de rédaction, le Word, le PDF, le diaporama et les photos à rapporter.
4. La veille de l'oral, relisez tous les encadrés « À retenir » et la partie 11.

À retenir – Les cinq règles d'or du stagiaire en santé publique

- On part toujours des besoins du public, jamais de ce qu'on a envie d'animer.
- Chaque chiffre cité a une source et une date.
- Chaque objectif est mesurable, et chaque objectif a son indicateur d'évaluation.
- Rien sur les personnes sans leur accord : ni photo, ni nom, ni donnée de santé.
- On note tout, tous les jours, dans le journal de bord.

Les exemples suivent un projet fictif unique, celui du centre social des Tilleuls (le même que dans le cours complet) : « Bien manger, petit budget, grand plaisir ». Ses chiffres sont inventés pour l'exercice et sont signalés comme tels. Les chiffres réels (enquêtes nationales, plans, lois) sont sourcés et datés.

Attention – Date de validité

Ce cours est à jour au 26 octobre 2026. Les plans de santé publique, les seuils réglementaires et les enquêtes changent. Avant de citer un chiffre dans votre dossier, vérifiez-le sur le site officiel et notez la date de consultation.

Partie 1 – Le cadre : stage, épreuve E5, compétences

1.1 Le stage d'interventions en santé publique

Le référentiel du BTS Diététique et nutrition (arrêté du 27 novembre 2024, publié au Journal officiel du 17 décembre 2024, première session d'examen en 2027) prévoit un stage intitulé « stage d'interventions en santé publique dans les domaines de la diététique et de la nutrition ». Le guide d'accompagnement pédagogique (29 avril 2025) en précise l'organisation.

Élément	Ce qu'il faut savoir
Durée	6 semaines au total
Organisation	Deux périodes dans la même structure : 2 à 3 semaines en fin de 1re année, puis 3 à 4 semaines au milieu de la 2e année (soit 3 + 3 ou 2 + 4 semaines)
But	Concevoir et réaliser tout ou partie d'un projet d'intervention en santé publique en nutrition
Lieux possibles	Toute structure où une intervention de santé publique en nutrition est possible, avec ou sans diététicien sur place
Évaluation	Épreuve E5, qui s'appuie sur ce stage
Convention	Une convention entre l'établissement et la structure pour chaque période de stage, signée avant le premier jour
Attestation	Remise en fin de stage par le responsable de la structure ; sans les attestations des stages de restauration collective et d'interventions en santé publique, vous ne pouvez pas passer l'E5
Durée réduite	En cas de positionnement ou d'aménagement de formation, la durée minimale est de 3 semaines

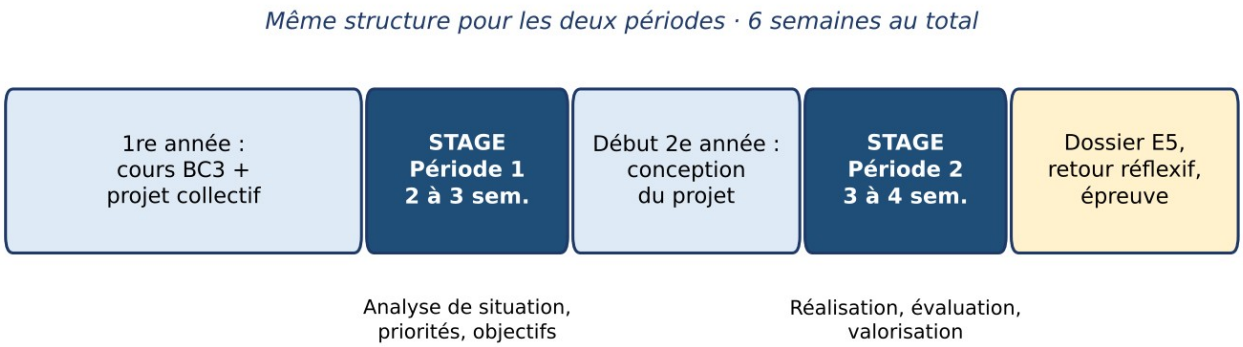


Figure 1 – Le stage sur les deux années de formation

1.1.1 Ce que vous faites à chaque période

Moment	Où	Ce que vous faites
Période 1 (fin de 1re année)	En structure, 2 à 3 semaines	Découvrir la structure et le public, analyser la situation, recueillir les besoins, poser un diagnostic, choisir les priorités et les objectifs
Entre les deux périodes (début de 2e année)	En établissement de formation	Concevoir le projet : fiche projet, plan d'action, budget, supports, plan de communication, outils d'évaluation

Moment	Où	Ce que vous faites
Période 2 (milieu de 2e année)	En structure, 3 à 4 semaines	Réaliser les actions (dont des ateliers), les évaluer, valoriser le projet
Après le stage	En établissement	Retour réflexif, rédaction du dossier de 10 pages, préparation de l'oral et de l'atelier culinaire

1.1.2 Les structures d'accueil possibles

Toutes les structures qui touchent une population, et pas seulement des patients, peuvent accueillir un stage de santé publique. Voici des exemples, avec le type de public.

Type de structure	Exemples	Public
Action sociale	Centre social, épicerie solidaire, CCAS, banque alimentaire, accueil de jour	Familles à faibles revenus, personnes isolées, personnes sans domicile
Éducation	Écoles, collèges, lycées (avec l'infirmière scolaire), service de restauration scolaire, université (service de santé étudiante)	Enfants, adolescents, étudiants
Petite enfance	PMI, crèches, relais petite enfance	Parents, jeunes enfants, assistantes maternelles
Collectivités	Service santé d'une mairie, contrat local de santé, atelier santé ville, projet alimentaire territorial	Habitants d'un quartier ou d'une commune
Santé	Maisons de santé pluriprofessionnelles, CPTS, centres de santé, services de prévention d'une caisse d'assurance maladie, mutuelles	Assurés, habitants, patients en prévention
Personnes âgées	Résidences autonomie, clubs seniors, services d'aide à domicile, EHPAD (volet prévention)	Seniors autonomes ou fragiles
Handicap	Foyers, ESAT, IME	Personnes en situation de handicap
Associations	Associations de prévention, de patients, sportives, de quartier	Variable
Entreprises	Service de santé au travail, restauration d'entreprise	Salariés

> **Astuce de stagiaire – Comment choisir sa structure**
>
> Choisissez une structure qui a un public régulier (vous retrouverez les mêmes personnes en période 2), un lieu où l'on peut cuisiner ou au moins faire des démonstrations, et un tuteur disponible. Une structure sans diététicien convient très bien : c'est même souvent là que le besoin en nutrition est le plus fort.

1.1.3 Les personnes qui vous encadrent

Personne	Rôle	Ce que vous lui devez
Tuteur ou tutrice en structure	Vous accueille, valide vos choix, vous présente le public et les partenaires, évalue votre stage	Un point par semaine au minimum, des comptes rendus écrits, la validation avant toute action auprès du public
Enseignant référent	Suit le stage depuis l'établissement, fait une visite ou un appel, aide à la méthode	Des nouvelles régulières, le planning, l'alerte en cas de difficulté
Professionnels de la structure	Animateurs, travailleurs sociaux, infirmiers, cuisiniers	Respect, écoute, information sur ce que vous faites
Le public	Les personnes à qui le projet s'adresse	Respect, confidentialité, honnêteté sur votre statut d'étudiant

Définition – Convention de stage

Document signé avant le stage par l'établissement de formation, la structure d'accueil et l'étudiant. Elle fixe les dates, les horaires, les missions, le nom du tuteur et les assurances. Sans convention signée, vous ne commencez pas le stage.

1.2 L'épreuve E5

L'épreuve E5 évalue le bloc de compétences 3. Elle a un coefficient de 4 et dure 3 h 30 au total, en deux temps indépendants. Elle est évaluée par des professeurs et des diététiciens. En contrôle en cours de formation (CCF), les deux temps deviennent deux situations d'évaluation, organisées au cours de la 2e année, avec le même niveau d'exigence.

Temps	Durée	Forme	Compétences évaluées
Temps 1	30 minutes	Exposé de 10 minutes maximum puis entretien de 20 minutes avec le jury, à partir d'un dossier écrit de 10 pages maximum hors annexes, sur le projet du stage	C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6
Temps 2	3 heures	Atelier culinaire dans un contexte imposé le jour de l'épreuve, avec au moins une préparation culinaire réalisée	C3.2

Erreurs fréquentes – Erreur fréquente

Croire que l'épreuve évalue le projet. Elle évalue vos compétences à travers le projet. Un projet qui a mal marché peut rapporter beaucoup de points si vous analysez pourquoi, avec des chiffres, et ce que vous changeriez.

Attention – Trois conditions pour être interrogé

- Avoir remis les attestations des stages de restauration collective et d'interventions en santé publique.
- Avoir déposé le dossier écrit selon les modalités et avant la date fixées par la circulaire de l'académie. Sans dépôt, ou après la date, l'épreuve n'est pas validée et le diplôme ne peut pas être délivré, même si vous êtes présent le jour de l'oral.
- Avoir conduit le projet pendant le stage (convention signée pour chaque période).

La partie 11 détaille les règles du dossier, sa rédaction et sa mise en forme.

1.3 Les six compétences du bloc 3

Code	Compétence	Ce que cela veut dire en stage
C3.1	Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition	Mener tout le projet : diagnostic, priorités, objectifs, plan d'action, mise en œuvre, évaluation, valorisation
C3.2	Concevoir et réaliser des ateliers culinaires adaptés au public visé	Préparer, animer et évaluer un atelier cuisine, avec fiches techniques, coûts, hygiène
C3.3	Participer à des activités de recherche appliquée en nutrition humaine	Construire un questionnaire, recueillir et traiter des données, calculer, présenter des résultats
C3.4	Assurer une veille scientifique, professionnelle et réglementaire	Chercher des sources fiables, les dater, les synthétiser, les citer
C3.5	Communiquer et interagir dans un contexte d'intervention en santé	Parler au public, animer un groupe, travailler avec les partenaires, rendre compte

Code	Compétence	Ce que cela veut dire en stage
C3.6	Maintenir son environnement numérique de travail sécurisé	Protéger les fichiers et les données, sauvegarder, utiliser les outils numériques et l'IA avec prudence

À retenir – Chaque jour de stage nourrit une compétence

Le Guide du stage jour par jour indique pour chaque journée la compétence travaillée et, dans l'encadré « Pour le dossier E5 », la partie du dossier qu'elle nourrit, la preuve à garder et la photo ou le document à rapporter. Notez dans votre journal de bord une preuve par compétence et par semaine : un document produit, une photo autorisée, un tableau, un compte rendu. Ces preuves deviendront vos annexes.

1.4 Les compétences psychosociales

Le guide d'accompagnement insiste sur les compétences psychosociales (CPS) pendant le stage. Ce sont aussi des outils de santé publique : beaucoup de programmes de prévention cherchent à les renforcer chez le public.

Définition – Compétences psychosociales

Selon l'OMS (1993), ce sont les capacités d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Santé publique France (2022) les classe en trois catégories : cognitives, émotionnelles et sociales, soit 9 compétences générales et 23 compétences spécifiques.

Catégorie (Santé publique France, 2022)	Exemples de compétences	En stage, cela donne
Cognitives	Avoir conscience de soi, maîtriser ses pensées, prendre des décisions, résoudre des problèmes	S'auto-évaluer après un atelier, choisir une priorité, réagir à un imprévu
Émotionnelles	Avoir conscience de ses émotions et de son stress, les réguler	Gérer le trac avant l'animation, garder son calme avec un participant difficile
Sociales	Communiquer de façon efficace et positive, développer des relations constructives, résoudre des difficultés	Écouter, reformuler, travailler avec l'équipe, demander de l'aide, accepter une critique

Les 10 compétences de la liste historique de l'OMS (1993), encore souvent citées, vont par paires : savoir résoudre les problèmes / savoir prendre des décisions ; avoir une pensée créative / une pensée critique ; savoir communiquer efficacement / être habile dans les relations interpersonnelles ; avoir conscience de soi / avoir de l'empathie ; savoir gérer son stress / ses émotions.

Préparer l'oral – À dire au jury

« Pendant le stage, j'ai surtout développé la gestion du stress : lors du premier atelier, j'ai perdu le fil quand deux participants parlaient en même temps. Ensuite, j'ai fixé des règles de groupe au début de chaque séance et j'ai préparé un conducteur minuté. Au troisième atelier, j'ai tenu le timing à cinq minutes près. »

Partie 2 – Les bases de la santé publique

2.1 Santé, santé publique, promotion de la santé

Définition – Santé (OMS, 1946)

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » Préambule de la Constitution de l'OMS, adopté en 1946, entré en vigueur en 1948.

Définition – Santé publique

Ensemble des actions organisées par la société pour protéger, promouvoir et rétablir la santé d'une population. Elle s'intéresse aux groupes (un quartier, une classe d'âge, les bénéficiaires d'une épicerie solidaire) et non à une personne seule.

La différence avec votre travail en BC1 (soin diététique) tient en une phrase : en BC1 vous aidez une personne, en BC3 vous agissez pour un groupe et sur son environnement.

	Approche clinique (BC1)	Approche de santé publique (BC3)
Cible	Un patient	Une population ou un groupe
Point de départ	Une demande de soin, une prescription	Un problème de santé observé dans un groupe
Outil de base	Bilan diététique individuel	Diagnostic de situation
Actions	Conseil, plan alimentaire, suivi	Information, éducation, ateliers, modification de l'environnement, plaidoyer
Évaluation	Évolution du patient	Indicateurs de processus et de résultat sur le groupe

2.1.1 Les trois grands modes d'intervention

Mode	Définition	Exemple en nutrition
Information pour la santé	Transmettre des connaissances sur la santé, ses risques et ses ressources	Affiche sur les repères de consommation, stand d'information
Éducation pour la santé	Aider une personne ou un groupe à acquérir des compétences pour faire des choix favorables à sa santé, en partant de ses représentations	Série d'ateliers cuisine où les participants apprennent à cuisiner les légumes secs
Promotion de la santé	Donner aux populations les moyens d'un plus grand contrôle sur leur santé, en agissant aussi sur l'environnement (Charte d'Ottawa, 1986)	Créer avec le centre social un groupement d'achat de fruits et légumes, faire évoluer le règlement de la cafétéria

Attention – L'éducation thérapeutique du patient n'est pas l'objet du stage

L'éducation thérapeutique du patient (ETP) s'adresse à des patients atteints d'une maladie chronique, dans un programme autorisé ou déclaré auprès de l'agence régionale de santé. Elle relève du soin (BC1). Un atelier de prévention pour des habitants n'est pas de l'ETP.

2.1.2 La Charte d'Ottawa (1986)

La Charte d'Ottawa, adoptée à la première conférence internationale pour la promotion de la santé (Ottawa, 21 novembre 1986), reste le texte de référence. Elle définit la promotion de la santé comme « le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci ».

Les 5 axes d'action	Exemple dans un projet nutrition
Élaborer une politique publique saine	Proposer à la mairie un critère « fruits locaux » dans le marché public de la cantine
Créer des milieux favorables	Installer une fontaine à eau et une corbeille de fruits au foyer des jeunes
Renforcer l'action communautaire	Former des habitants relais qui animeront les ateliers après votre départ
Acquérir des aptitudes individuelles	Ateliers cuisine, lecture d'étiquettes
Réorienter les services de santé	Intégrer un temps de prévention nutritionnelle dans la maison de santé

Les 3 stratégies de la Charte : plaider (convaincre les décideurs), conférer les moyens (rendre les personnes capables d'agir), servir de médiateur (faire travailler ensemble les acteurs).

À retenir – Un projet de promotion de la santé

Il agit à la fois sur les personnes (connaissances, compétences) et sur leur environnement (offre alimentaire, prix, lieux). Il fait participer le public dès le diagnostic. Plus votre projet coche d'axes d'Ottawa, plus il est solide.

2.2 Les déterminants de la santé

Définition – Déterminant de santé

Facteur personnel, social, économique ou environnemental qui influence l'état de santé d'une personne ou d'une population.

Le rapport Lalonde (Canada, 1974) a été le premier à classer les déterminants en quatre champs : biologie humaine, environnement, habitudes de vie, organisation des soins. Le modèle le plus utilisé aujourd'hui est celui de Dahlgren et Whitehead (1991), en couches successives.



D'après Dahlgren et Whitehead (1991). Exemples de conditions de vie : alimentation disponible, éducation, emploi, logement, eau et assainissement, services de santé.

Figure 2 – Les déterminants de la santé selon Dahlgren et Whitehead (1991)

Appliqué à l'alimentation, le modèle se lit ainsi :

Couche	Déterminants de l'alimentation	Comment les repérer en stage
Facteurs individuels	Âge, sexe, maladies, goûts, connaissances, compétences culinaires	Questionnaire, entretien
Mode de vie	Horaires de repas, grignotage, activité physique, sommeil, écrans	Questionnaire, rappel de 24 heures, observation
Réseaux sociaux	Famille, isolement, culture d'origine, pairs, religion	Entretien, groupe de parole
Conditions de vie et de travail	Revenus, logement, équipement de cuisine, emploi, temps disponible, accès aux commerces, éducation	Données de la structure, observation, données du territoire
Conditions générales	Prix des aliments, publicité, politiques publiques, offre alimentaire du quartier, culture alimentaire, climat	Données nationales et territoriales, veille

Définition – Inégalités sociales de santé

Différences d'état de santé entre groupes sociaux, systématiques, évitables et injustes. Elles suivent un gradient : la santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale, pas seulement entre « pauvres » et « riches ».

Définition – Universalisme proportionné

Principe proposé par Michael Marmot (rapport « Fair Society, Healthy Lives », 2010) : agir pour toute la population, avec une intensité plus forte pour les groupes qui en ont le plus besoin. Exemple : ateliers ouverts à tous les parents de l'école, avec en plus un accompagnement des familles suivies par l'épicerie solidaire.

2.3 Les niveaux de prévention

Il existe deux classifications. Il faut savoir les deux, car le jury peut demander de qualifier votre action.

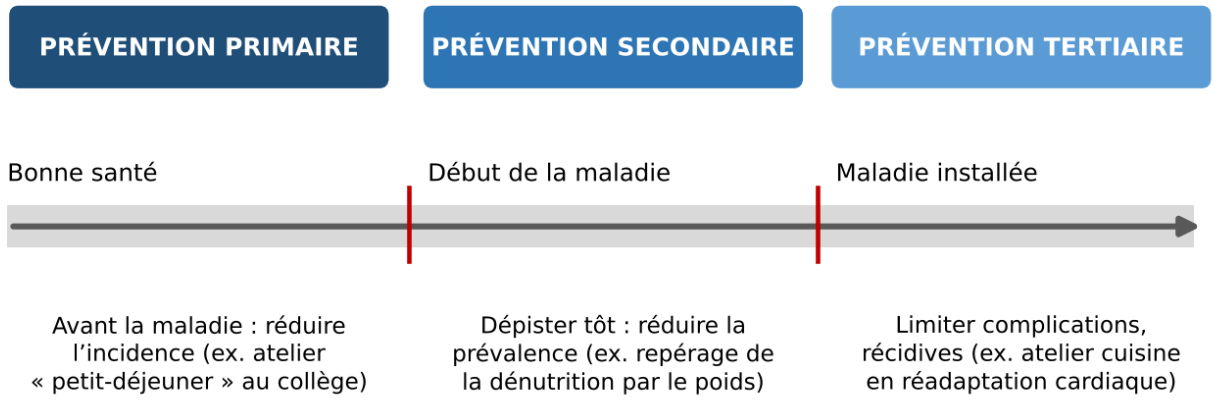


Figure 3 – Les trois niveaux de prévention selon l'OMS

Classification de l'OMS (selon le moment)	Définition	Exemple
Primaire	Avant l'apparition de la maladie : réduire l'incidence	Atelier « petit-déjeuner » au collège
Secondaire	Au tout début de la maladie : dépister tôt, réduire la prévalence	Repérage de la dénutrition par la pesée en résidence autonomie
Tertiaire	Maladie installée : limiter les complications, les récidives, les incapacités	Atelier cuisine en réadaptation cardiaque

Classification de Gordon (1983, selon le public visé)	Définition	Exemple
Universelle	Toute la population, sans tenir compte du risque	Campagne nationale sur les fruits et légumes
Sélective	Un sous-groupe exposé à un risque plus élevé	Ateliers pour les familles d'une épicerie solidaire
Indiquée	Des personnes qui ont déjà des facteurs de risque ou des signes	Programme pour des enfants en surpoids

Méthode – Qualifier son action en 4 réponses

1. Mode : information, éducation ou promotion de la santé ?
2. Niveau OMS : primaire, secondaire ou tertiaire ?
3. Type selon Gordon : universelle, sélective ou indiquée ?
4. Axes d'Ottawa : lesquels sont touchés ?

Exemple fictif des Tilleuls : éducation pour la santé, avec un volet de promotion (création d'un panier solidaire) ; prévention primaire ; sélective (familles à faibles revenus) ; axes « aptitudes individuelles », « action communautaire » et « milieux favorables ».

2.4 Les indicateurs de santé et les calculs de base

Vous aurez à lire, citer et calculer des indicateurs. Voici ceux qui servent le plus, avec un exemple calculé.

Définition – Prévalence

Proportion de personnes atteintes d'une maladie (ou présentant une caractéristique) à un moment donné, dans une population. Prévalence = nombre de cas présents / effectif de la population au même moment.

Définition – Incidence

Nombre de nouveaux cas apparus pendant une période donnée, rapporté à la population à risque au début de la période. Taux d'incidence = nouveaux cas / (population à risque × durée).

Calcul posé – Exemple 1 – Prévalence (données fictives)

Dans une école de 240 élèves, l'infirmière compte 31 élèves en surpoids (obésité comprise) au bilan de rentrée.

Prévalence = 31 / 240 = 0,129, soit 12,9 %.

Interprétation : environ 13 élèves sur 100 sont en surpoids le jour du bilan.

Calcul posé – Exemple 2 – Incidence (données fictives)

Une résidence de 80 personnes âgées non dénutries en janvier. Pendant l'année, 6 nouvelles personnes sont repérées dénutries.

Incidence cumulée sur un an = 6 / 80 = 0,075, soit 7,5 % par an.

Définition – Indice de masse corporelle (IMC)

IMC = poids (kg) / taille (m)². Chez l'adulte (OMS) : moins de 18,5 = insuffisance pondérale ; 18,5 à 24,9 = corpulence normale ; 25 à 29,9 = surpoids ; 30 ou plus = obésité. Chez l'enfant, on utilise les courbes de corpulence selon l'âge et le sexe, jamais ces seuils adultes. Chez la personne âgée, les critères de dénutrition de la HAS (2021 pour les 70 ans et plus) utilisent un seuil d'IMC de 22.

Calcul posé – Exemple 3 – IMC

Une femme de 68 kg mesurant 1,62 m : IMC = 68 / (1,62 × 1,62) = 68 / 2,6244 = 25,9 kg/m². Corpulence : surpoids.

2.4.1 Quelques chiffres nationaux à connaître (à vérifier avant de les citer)

Indicateur	Valeur	Source et date
Adultes de 18 à 74 ans en obésité	17 %	Étude Esteban 2014-2016, Santé publique France (résultats publiés en 2017)
Adultes de 18 à 74 ans en surpoids, obésité comprise	54 % des hommes, 44 % des femmes	Esteban 2014-2016
Enfants de 6 à 17 ans en surpoids, obésité comprise	17 %, dont 4 % d'obésité	Esteban 2014-2016

Indicateur	Valeur	Source et date
Prochaine grande enquête	Albane : pilote en septembre 2024, premier cycle lancé en juin 2025, collecte jusqu'à fin 2026, premiers résultats annoncés début 2028	Santé publique France et Anses

Attention – Ne citez jamais un chiffre sans le vérifier

Les chiffres nationaux datent souvent de plusieurs années. Écrivez la source et l'année de recueil des données, par exemple : « 17 % des adultes de 18 à 74 ans sont en obésité (Esteban, données 2014-2016) ». Cherchez toujours s'il existe un chiffre plus récent, régional ou local (observatoire régional de la santé, ARS, Insee).

2.4.2 Les pourcentages sans erreur

La plupart des erreurs de dossier viennent des pourcentages.

Ce que vous voulez dire	Calcul	Exemple
Une part	partie / total × 100	18 réponses « oui » sur 42 : 18 / 42 × 100 = 42,9 %
Une évolution en %	(valeur finale − valeur initiale) / valeur initiale × 100	Score de 8 à 11 : (11 − 8) / 8 × 100 = + 37,5 %
Une évolution en points	pourcentage final − pourcentage initial	30 % puis 45 % : + 15 points (et non + 15 %)
Un taux de participation	présents / attendus × 100	9 présents sur 12 inscrits : 75,0 %

Erreurs fréquentes – Erreur fréquente : les points et les pourcents

Si la part des participants qui connaissent les repères passe de 30 % à 45 %, elle augmente de 15 points de pourcentage, ce qui fait une hausse relative de (45 − 30) / 30 × 100 = 50 %. Écrire « + 15 % » est faux.

Erreurs fréquentes – Erreur fréquente : les petits effectifs

Avec 8 participants, une personne pèse 12,5 %. Écrivez plutôt « 6 participants sur 8 » que « 75 % », ou donnez les deux : « 6 sur 8 (75 %) ». N'affichez pas de décimale avec un effectif de moins de 20.

Partie 3 – Politiques publiques, acteurs et sources de données

3.1 Les plans nationaux en vigueur au 26 octobre 2026

Attention – Le piège du PNNS 4

Le PNNS 4 couvrait 2019-2023. Le plan en vigueur depuis le 8 avril 2026 est le PNNS 5 (2026-2030). Citer le PNNS 4 comme plan actuel dans un dossier de 2027 fait perdre des points immédiatement.

Plan	Période	Ce qu'il faut retenir	Source (date)
Programme national nutrition santé 5 (PNNS 5)	2026-2030	Lancé le 8 avril 2026, 3 axes et 20 mesures	Ministère chargé de la santé (avril 2026)
Programme national pour l'alimentation 4 (PNA 4)	Lancé en même temps que le PNNS 5	Volet « alimentation » de la politique nutritionnelle, piloté par le ministère de l'Agriculture ; lisez ses axes sur le site du ministère avant de le citer	Ministère de l'Agriculture (avril 2026)
Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat (SNANC)	2025-2030	Prévue par la loi Climat et résilience (2021, article 265), publiée le 11 février 2026 ; relie santé, climat et souveraineté alimentaire ; prévoit de limiter la consommation de viande et vise des projets alimentaires territoriaux couvrant au moins 80 % du territoire	Gouvernement (février 2026)
Stratégie nationale de santé (SNS)	2023-2033	Cadre général de la politique de santé, dans lequel s'inscrivent la prévention et la promotion de la santé	Ministère chargé de la santé

3.1.1 Le PNNS 5 en détail

Les trois axes du PNNS 5 :

1. Des environnements nutritionnels durables et favorables à la santé.
2. Des comportements alimentaires et d'activité physique sains et durables.
3. Des entreprises, des établissements scolaires et d'enseignement supérieur promoteurs de santé.

Quelques objectifs chiffrés du plan :

Objectif du PNNS 5	Cible
Surpoids des enfants	Baisse de 30 %, et de 20 % dans les familles les plus défavorisées
Consommation de produits biologiques	12 %
Nutri-Score	Utilisé par 40 % des personnes et affiché sur 75 % des ventes
Allaitement	85 % des bébés allaités à la naissance

Méthode – Relier son projet au PNNS 5 (exemple des Tilleuls)

Le projet « Bien manger, petit budget, grand plaisir » s'inscrit dans l'axe 2 (comportements alimentaires sains et durables : cuisiner les légumes secs, réduire le gaspillage) et touche l'axe 1 (environnement favorable : panier solidaire). Il contribue à l'objectif de réduction du surpoids des enfants dans les familles défavorisées.

Dans le dossier, écrivez une phrase de ce type, avec la référence datée du plan.

3.1.2 Les repères de consommation

Les repères alimentaires pour les adultes publiés par Santé publique France en 2019, à partir de l'avis du Haut Conseil de la santé publique de 2017, sont la base de vos messages. Vérifiez sur le site mangerbouger.fr qu'ils sont toujours en vigueur le jour où vous les utilisez.

Groupe	Repère pour les adultes
Fruits et légumes	Au moins 5 portions par jour (une portion = 80 à 100 g)
Légumes secs	Au moins 2 fois par semaine
Féculents complets	Au moins un par jour
Fruits à coque non salés	Une petite poignée par jour
Produits laitiers	2 par jour
Poisson	2 fois par semaine, dont un poisson gras
Viande (hors volaille)	Limiter à 500 g par semaine
Charcuterie	Limiter à 150 g par semaine
Boissons sucrées, produits gras, sucrés, salés et ultra-transformés	Limiter
Sel	Réduire
Eau	La seule boisson indispensable
Activité physique	Au moins 30 minutes d'activité dynamique par jour ; réduire le temps assis

Astuce de stagiaire – Les repères sont des points de départ, pas des ordres

En atelier, on ne dit pas « vous devez manger 5 fruits et légumes ». On demande « Combien en mangez-vous ? Qu'est-ce qui serait facile d'ajouter ? » La partie 4 explique pourquoi.

3.2 Les lois qui comptent pour un projet en nutrition

Texte	Date	Ce qu'il change pour vous
Loi relative à la politique de santé publique	9 août 2004	Inscrit la santé publique comme responsabilité de l'État ; base du PNNS
Loi « Hôpital, patients, santé et territoires » (HPST)	21 juillet 2009	Crée les agences régionales de santé (ARS) et les contrats locaux de santé
Loi d'avenir pour l'agriculture	13 octobre 2014	Crée les projets alimentaires territoriaux (PAT)
Loi de modernisation de notre système de santé	26 janvier 2016	Base légale de l'étiquetage nutritionnel simplifié (Nutri-Score, arrêté du 31 octobre 2017)
Loi EGalim	30 octobre 2018	En restauration collective : au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits biologiques (depuis le 1er janvier 2022) ; plan pluriannuel de diversification des protéines ; lutte contre le gaspillage
Loi Climat et résilience	22 août 2021	Menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire ; prévoit la SNANC (article 265)
Arrêté modifiant le Nutri-Score	14 mars 2025	Nouvel algorithme, avec une période de transition de deux ans pour les fabricants

À retenir – Pourquoi citer les lois ?

Pour montrer au jury que votre projet s'inscrit dans le cadre officiel. Un projet en restauration scolaire doit citer EGalim et la loi Climat et résilience. Un projet sur l'étiquetage doit citer le Nutri-Score et sa révision de 2025.

3.3 Qui fait quoi : les acteurs

Niveau	Acteur	Rôle utile pour votre projet
National	Ministère chargé de la santé (Direction générale de la santé)	Pilote le PNNS
National	Ministère de l'Agriculture (Direction générale de l'alimentation)	Pilote le PNA, la restauration collective, la sécurité sanitaire des aliments
National	Santé publique France	Surveillance, enquêtes, campagnes, outils (mangerbouger.fr), données (plateforme Géodes)
National	Haut Conseil de la santé publique (HCSP)	Expertise, avis sur les repères nutritionnels
National	Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses)	Évaluation des risques, études INCA, table de composition Ciqual
National	Haute Autorité de santé (HAS)	Recommandations professionnelles (dénutrition, obésité)
National	Caisse nationale de l'Assurance maladie (CNAM) et caisses primaires (CPAM)	Programmes de prévention, financement d'actions
Régional	Agence régionale de santé (ARS)	Projet régional de santé (PRS), appels à projets, contrats locaux de santé
Régional	Observatoire régional de la santé (ORS)	Données de santé du territoire
Régional	Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé (IREPS)	Formation, documentation, prêt d'outils d'animation, aide méthodologique
Local	Commune, intercommunalité, département	Contrat local de santé, atelier santé ville, PAT, restauration scolaire (communes), PMI (départements)
Local	Associations, centres sociaux, épiceries solidaires	Accès au public, lieux, bénévoles
Local	Professionnels de santé de proximité	Maison de santé, CPTS, pharmacien, médecin traitant, infirmière scolaire

Définition – Contrat local de santé (CLS)

Accord signé entre l'ARS et une collectivité pour mener des actions de santé adaptées au territoire. Si la commune de votre structure a un CLS, cherchez sa fiche action « nutrition » : votre projet pourra s'y rattacher et y trouver des partenaires.

Définition – Projet alimentaire territorial (PAT)

Projet construit par les acteurs d'un territoire (collectivités, agriculteurs, distributeurs, associations, habitants) pour relocaliser l'alimentation et la rendre plus durable et plus accessible. Au 1er juillet 2025, 450 PAT étaient reconnus par le ministère de l'Agriculture.

3.4 Où trouver les données pour le diagnostic

Besoin	Source	Ce que vous y trouvez
Population du quartier ou de la commune	Insee (dossiers complets par commune, quartiers prioritaires de la politique de la ville)	Âge, taille des ménages, revenus, taux de pauvreté, chômage
Santé du territoire	ORS, Géodes (Santé publique France), ScoreSanté (Fédération nationale des ORS)	Mortalité, maladies chroniques, indicateurs par département ou région
Consommation alimentaire nationale	Études INCA 3 (Anses, 2017), Esteban (Santé publique France, 2014-2016), Albane (en cours)	Apports, consommations, corpulence
Composition des aliments	Table Ciqual (Anses)	Énergie et nutriments pour 100 g
Politiques locales	Site de l'ARS (PRS), site de la commune (CLS), site du ministère de l'Agriculture (carte des PAT)	Priorités du territoire, partenaires
Données de la structure	Rapport d'activité, projet social, fichiers anonymisés de fréquentation	Nombre de bénéficiaires, profils, activités existantes
Littérature	Santé publique France, HAS, HCSP, Cairn, PubMed, Google Scholar	Interventions qui ont marché ailleurs

À retenir – Données froides et données chaudes

Les données froides existent déjà (statistiques, rapports). Les données chaudes sont celles que vous recueillez vous-même auprès du public et des professionnels (questionnaires, entretiens, observation). Un bon diagnostic croise les deux.

Partie 4 – Comprendre le public

4.1 Pourquoi les gens mangent ce qu'ils mangent

Savoir ne suffit pas pour changer. La plupart des personnes savent qu'il faut manger des fruits et des légumes. Si elles n'en mangent pas, c'est pour des raisons de prix, de goût, de temps, d'habitude, de culture, d'équipement ou d'émotion. Votre diagnostic doit trouver ces raisons.

Facteur	Questions à se poser sur votre public
Biologique	Âge, appétit, état dentaire, maladies, grossesse, traitements
Psychologique	Goûts et dégoûts, plaisir, stress, image du corps, motivation
Social et culturel	Habitudes familiales, religion, culture d'origine, repas partagés ou seul
Économique	Budget alimentaire, aides, prix perçus
Matériel	Équipement de cuisine, stockage, énergie, accès aux commerces, transport
Cognitif	Connaissances, compétences culinaires, capacité à lire une étiquette
Environnemental	Offre du quartier, publicité, restauration rapide proche

Définition – Représentations

Idées, croyances et images qu'une personne a sur un sujet (par exemple « manger sain coûte cher », « les légumes secs font grossir »). Elles se recueillent avant d'éduquer : on ne corrige bien une idée qu'après l'avoir entendue.

4.2 Le changement de comportement : le modèle de Prochaska et DiClemente

Le modèle transthéorique (Prochaska et DiClemente, années 1980) décrit les stades par lesquels passe une personne qui change un comportement. Il aide à adapter le message.

Stade	Ce que pense la personne	Ce que vous faites
Pré-contemplation	« Je n'ai pas de problème. »	Informer sans juger, susciter la curiosité, ne pas insister
Contemplation	« Il faudrait peut-être, mais… »	Faire peser le pour et le contre, écouter l'ambivalence
Préparation	« Je vais essayer le mois prochain. »	Aider à fixer un petit objectif concret
Action	« Je cuisine des lentilles une fois par semaine. »	Encourager, donner des solutions aux obstacles
Maintien	« Je le fais depuis 6 mois. »	Valoriser, prévenir la rechute
Rechute (possible à tout moment)	« J'ai arrêté. »	Dédramatiser : la rechute fait partie du chemin

Astuce de stagiaire – Dans un groupe, tous les stades coexistent

Prévoyez une activité qui parle à chacun : une dégustation (pré-contemplation), un échange sur les freins (contemplation), une recette à refaire chez soi (préparation, action).

4.3 Quelques notions de psychologie sociale

Notion	Explication	Conséquence pour l'animation
Effet de groupe	On change plus facilement quand le groupe change	Faire décider le groupe (choix de la recette)
Engagement	Un petit acte librement choisi favorise les actes suivants	Proposer un engagement écrit et volontaire (« cette semaine j'essaie… »)
Dissonance cognitive	Inconfort quand nos actes contredisent nos idées	Ne pas culpabiliser : cela bloque au lieu de faire changer
Sentiment d'efficacité personnelle (Bandura)	Croire qu'on est capable de réussir une action	Faire réussir quelque chose dès la première séance (une recette simple)
Stigmatisation	Se sentir désigné comme « mauvais élève »	Ne jamais présenter l'atelier comme « pour les personnes en surpoids » ou « pour les pauvres »

Erreurs fréquentes – Erreur fréquente : la règle des « 7 % de mots »

Une idée répandue affirme que 93 % de la communication passe par le non-verbal. C'est une mauvaise lecture des expériences de Mehrabian (1967), qui portaient seulement sur des mots isolés exprimant une émotion. Ne citez pas ce chiffre comme une règle générale.

4.4 La littératie en santé

Définition – Littératie en santé

Capacité d'une personne à trouver, comprendre, évaluer et utiliser une information de santé pour prendre des décisions. Une faible littératie est fréquente et invisible : la personne ne le dit pas.

Signes possibles d'une faible littératie : la personne dit avoir oublié ses lunettes, remplit le questionnaire « à la maison », regarde les images plutôt que le texte, répond « oui » à tout.

Méthode – Adapter les supports : le FALC

Le FALC (« facile à lire et à comprendre ») suit des règles européennes (Inclusion Europe, 2009). Les principales :

- une idée par phrase, des phrases courtes, des mots de tous les jours ;
- pas de sigles, pas d'abréviations, pas de pourcentages (« 1 personne sur 2 » plutôt que « 50 % ») ;
- police sans empattement (Arial, Verdana), au moins 14 points, aligné à gauche ;
- une image ou un pictogramme à côté de chaque idée importante ;
- relecture par une personne du public concerné.

Méthode – Vérifier la compréhension : le teach-back

Après une explication, demandez à la personne de redire avec ses mots : « Pour être sûr d'avoir bien expliqué, pouvez-vous me dire comment vous allez faire la recette chez vous ? » C'est vous que vous testez, pas la personne.

4.5 Les publics du stage : points d'attention

Public	Points d'attention	Idées qui fonctionnent
Jeunes enfants (3-6 ans)	Concentration courte (10 à 15 minutes), sécurité (couteaux, chaleur), allergies, autorisation des parents	Toucher, sentir, goûter, jeux, histoires, néophobie : proposer sans forcer, plusieurs fois
Enfants (6-11 ans)	Lecture variable, besoin de bouger	Jeux de tri, défis, petite cuisine sans cuisson
Adolescents	Recherche d'autonomie, image de soi, influence des pairs et des réseaux sociaux	Débats, décryptage de publicités, recettes rapides et peu chères, ne pas faire la morale
Étudiants	Budget serré, peu d'équipement, manque de temps	Recettes en 15 minutes, batch cooking, courses à petit prix
Familles en situation de précarité	Budget, honte, équipement, fatigue	Recettes à moins d'un euro la portion, valoriser les savoir-faire existants
Personnes allophones	Langue, habitudes culinaires différentes	Pictogrammes, démonstration, interprète ou habitant relais, recettes du pays d'origine
Femmes enceintes et jeunes parents	Peurs, idées reçues, listériose, toxoplasmose	Groupes d'échange avec la PMI, diversification alimentaire
Personnes âgées autonomes	Risque de dénutrition, isolement, appétit diminué, dentition	Repas partagés, enrichissement, protéines à chaque repas, pas de régime restrictif sans avis médical
Personnes en situation de handicap	Compréhension, motricité, troubles de la déglutition	FALC, matériel adapté, textures (IDDSI, voir 8.6)
Salariés	Horaires, repas sur le pouce, travail posté	Gamelle équilibrée, collation, ateliers courts sur le temps de pause

Point de vigilance – Les sujets sensibles

Le poids, le budget, la religion, la santé mentale et les troubles du comportement alimentaire se traitent avec tact. Ne pesez jamais quelqu'un en public. Si une personne vous confie une difficulté de santé, orientez-la vers un professionnel (médecin, diététicien, travailleur social) et informez votre tuteur, sans divulguer plus que nécessaire.

Partie 5 – Éthique, droit et numérique

5.1 Les principes éthiques de l'intervention

Principe	En pratique
Respect de l'autonomie	La participation est libre ; on peut refuser ou quitter un atelier sans se justifier
Bienfaisance	L'action vise un bénéfice réel pour le public
Non-malfaisance	Pas de culpabilisation, pas de stigmatisation, pas de conseil dangereux (régime restrictif, aliment allergène non signalé)
Justice	Les ressources vont d'abord à ceux qui en ont le plus besoin (universalisme proportionné)
Confidentialité	Ce qui est dit dans l'atelier reste dans l'atelier
Honnêteté	Vous présentez votre statut d'étudiant, vous ne promettez pas de résultat de santé

5.2 Le secret professionnel et la discrétion

En stage, vous êtes tenu à la discrétion sur tout ce que vous voyez et entendez. Le secret professionnel est puni par l'article 226-13 du Code pénal : la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Exemple – Bonnes pratiques

- Ne citez aucun nom, aucune adresse, aucun détail permettant de reconnaître une personne dans le journal de bord, le dossier ou sur les réseaux sociaux.
- Remplacez les personnes par des codes (P1, P2…) ou des prénoms fictifs signalés comme tels.
- Ne parlez pas des bénéficiaires dans les transports ou à la pause de midi au café.

5.3 Le RGPD appliqué au stage

Le règlement général sur la protection des données (règlement européen 2016/679, applicable depuis le 25 mai 2018) protège toute information qui permet d'identifier une personne, directement ou indirectement. Les données de santé sont des données sensibles, protégées encore plus strictement.

Principe du RGPD	Ce que vous faites dans le stage
Finalité	Vous écrivez à quoi servent les données (« évaluer l'atelier ») et vous ne les utilisez pour rien d'autre
Minimisation	Vous ne demandez que ce qui est utile : pas de nom, pas de date de naissance si l'âge par tranche suffit
Information et consentement	En tête du questionnaire : qui recueille, pourquoi, anonymat, caractère facultatif, durée de conservation, contact
Exactitude	Vous saisissez les données sans les modifier
Durée de conservation limitée	Vous supprimez les données brutes à la fin de l'épreuve (date écrite à l'avance)
Sécurité	Fichiers sur un espace protégé par mot de passe, pas sur une clé USB perdue ou un ordinateur partagé

Modèle à recopier – Mention à placer en tête d'un questionnaire (à adapter)

Ce questionnaire est proposé par [prénom], étudiant(e) en BTS Diététique et nutrition, en stage au [structure]. Il sert à mieux connaître vos habitudes pour préparer des ateliers adaptés. Il est anonyme : n'écrivez pas votre nom. Vous êtes libre de ne pas répondre ou de ne pas répondre à certaines questions. Les réponses seront détruites au plus tard le [date]. Pour toute question : [contact de la structure].

Attention – Recherche ou évaluation ?

Un questionnaire anonyme d'évaluation d'une action n'est pas une recherche impliquant la personne humaine au sens de la loi Jardé (5 mars 2012). Si votre projet comportait un recueil de données de santé pour produire des connaissances générales (par exemple mesurer une glycémie), il faudrait un cadre réglementaire spécifique : ne le faites pas en stage sans l'avis de votre tuteur et de votre enseignant.

5.4 Le droit à l'image

Toute personne a droit au respect de sa vie privée (article 9 du Code civil), ce qui inclut son image. Pour photographier ou filmer une personne reconnaissable et utiliser l'image, il faut son autorisation écrite, précise (quel support, quelle durée) et révocable. Pour un mineur, il faut l'autorisation des deux titulaires de l'autorité parentale et l'avis du mineur : la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 rappelle que les parents protègent ensemble le droit à l'image de leur enfant et l'y associent selon son âge (article 372-1 du Code civil). La liste des photos à rapporter et les modèles d'autorisation sont dans la partie 11 (11.8).

Astuce de stagiaire – Photographier sans risque

Photographiez les mains, les plats, le matériel, les participants de dos. Utilisez l'appareil de la structure, pas votre téléphone personnel, et effacez les photos inutiles.

5.5 L'environnement numérique sécurisé (C3.6)

Risque	Mesure simple
Perte de fichiers	Règle 3-2-1 : 3 copies, sur 2 supports différents, dont 1 hors du lieu (cloud de l'établissement)
Piratage du compte	Mot de passe long et unique (une phrase de passe de 12 caractères ou plus), double authentification
Hameçonnage (phishing)	Ne pas cliquer sur un lien inattendu, vérifier l'adresse de l'expéditeur, signaler au service informatique
Fuite de données	Pas de données personnelles dans un courriel non protégé, ni dans un outil d'IA en ligne
Ordinateur partagé	Se déconnecter, ne pas enregistrer le mot de passe dans le navigateur
Nommage confus	Nommage clair et daté : 2027-03-12_Questionnaire_besoins_v2.docx

Définition – Identité numérique

Ensemble des traces qu'une personne laisse en ligne. Pendant le stage, vous représentez la structure : pas de publication sur le stage, le public ou les collègues sur vos réseaux personnels sans accord.

5.5.1 L'intelligence artificielle en stage

L'IA générative peut aider à reformuler un texte, proposer des idées d'animation ou corriger l'orthographe. Le règlement européen sur l'IA (AI Act, règlement (UE) 2024/1689) encadre son usage en Europe. Il a été modifié

par le règlement (UE) 2026/1744 du 24 juillet 2026, qui décale certaines échéances ; vérifiez la version en vigueur sur EUR-Lex avant de le citer.

À retenir – Les quatre règles de l'IA en stage

- Aucune donnée personnelle ni donnée de santé du public dans un outil d'IA.
- Tout contenu produit par l'IA est vérifié sur une source officielle : l'IA peut inventer des chiffres et des références.
- Vous dites au jury et au tuteur ce que vous avez fait avec l'IA (transparence).
- Le dossier E5 reste votre travail : l'IA ne rédige pas l'analyse à votre place.

Partie 6 – La démarche de projet en santé publique, étape par étape

6.1 Vue d'ensemble

Un projet de santé publique suit un cycle en six étapes. La communication, l'éthique et le respect du RGPD accompagnent toutes les étapes.

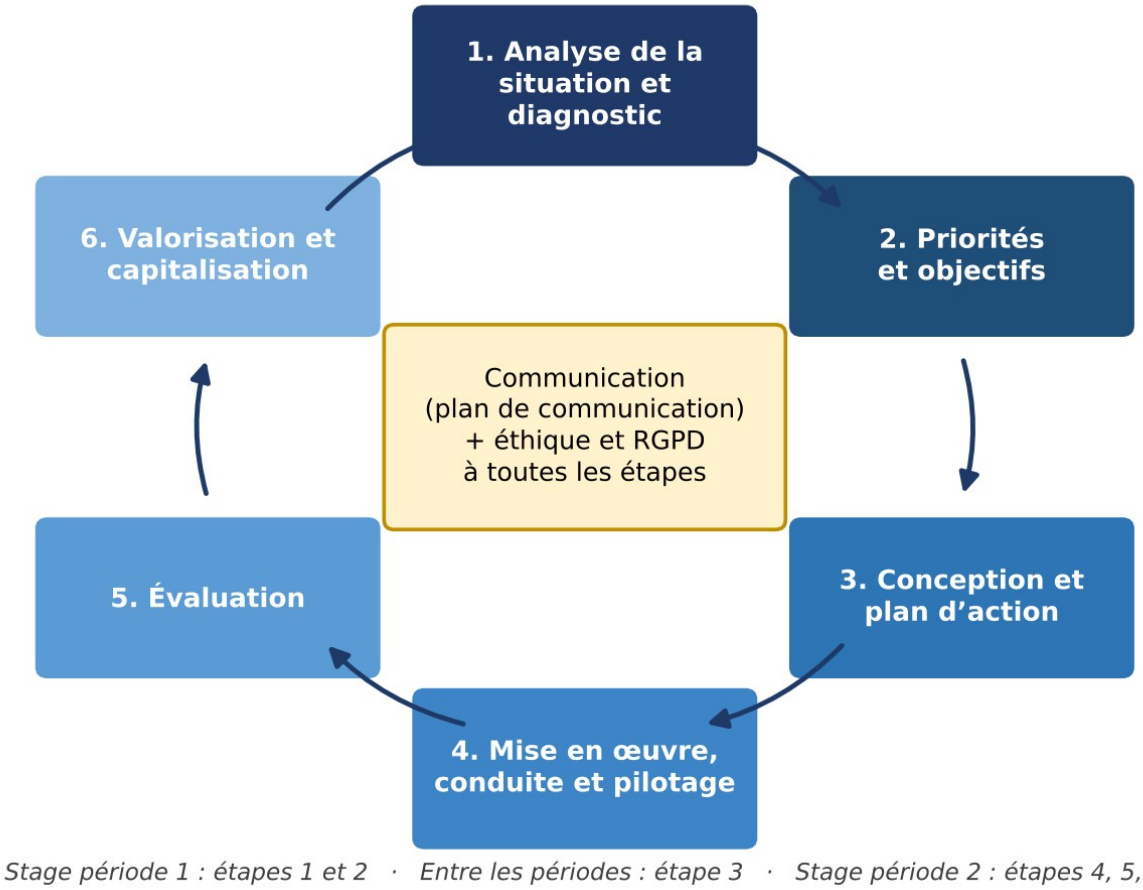


Figure 4 – Le cycle de la démarche de projet et sa place dans le stage

Étape	Question à laquelle elle répond	Période du stage	Production principale
1. Analyse de la situation	Quelle est la situation ? Quels sont les besoins ?	Période 1	Diagnostic écrit, arbre à problèmes
2. Priorités et objectifs	Sur quoi agir en premier ? Pour obtenir quoi ?	Fin de période 1	Grille de priorisation, arbre des objectifs
3. Conception	Comment ? Avec qui ? Quand ? Combien ?	Entre les périodes	Fiche projet, plan d'action, budget, Gantt, supports, outils d'évaluation
4. Mise en œuvre	Qu'est-ce qu'on fait concrètement ?	Période 2	Ateliers réalisés, comptes rendus, conducteurs
5. Évaluation	Est-ce que cela a marché ? Pourquoi ?	Période 2	Tableau de bord, analyse, limites
6. Valorisation	Qu'est-ce qu'on transmet ? Comment continuer ?	Fin de période 2	Restitution, livret, transmission, auto-évaluation

6.2 Étape 1 : l'analyse de la situation (le diagnostic)

Définition – Diagnostic de situation

Description argumentée de l'état de santé, des comportements, des besoins et des ressources d'une population, qui permet d'identifier les problèmes sur lesquels agir. Il est partagé avec la structure et, si possible, avec le public.

6.2.1 Les quatre types de besoins (Bradshaw, 1972)

Type de besoin	Défini par	Exemple aux Tilleuls (fictif)	Outil de recueil
Normatif	Un expert, une norme	Les repères disent au moins 2 fois par semaine de légumes secs ; les familles en mangent moins	Comparaison avec les repères, données nationales
Ressenti	Ce que la personne pense manquer	« Je ne sais pas cuisiner les lentilles »	Questionnaire, entretien
Exprimé	Ce que la personne demande	Demandes d'ateliers cuisine notées par l'accueil du centre social	Registre des demandes, entretiens avec les professionnels
Comparatif	Comparaison avec un autre groupe	Le quartier a un taux de pauvreté plus élevé que la commune	Insee, ORS

À retenir – Un besoin solide est confirmé par au moins deux types

Le jury apprécie un besoin normatif (les chiffres) confirmé par un besoin ressenti ou exprimé (la parole du public). Un projet construit seulement sur l'avis du stagiaire est fragile.

6.2.2 Le plan du diagnostic

1. La structure : statut, missions, public, équipe, locaux, matériel, budget, partenaires, actions déjà menées.
2. Le territoire : population, âge, revenus, quartier prioritaire ou non, offre alimentaire (commerces, marchés, restauration rapide), transports.
3. Les données de santé : indicateurs nationaux, régionaux et locaux, datés.
4. Le cadre politique : PNNS 5, SNANC, PRS, CLS, PAT.
5. Les données recueillies auprès du public et des professionnels : méthode, effectif, résultats principaux.
6. La synthèse : problèmes repérés, besoins (avec leur type), ressources et freins.

6.2.3 Les outils de recueil

Outil	Pour quoi faire	Avantages	Limites	Partie du cours
Observation	Voir ce qui se passe réellement (repas, courses, ateliers existants)	Pas de déclaratif	Subjectivité de l'observateur, effet de présence	9.4
Questionnaire	Recueillir des données chiffrées auprès de nombreuses personnes	Comparable, chiffrable	Déclaratif, problème de littératie, questions fermées réductrices	9.3
Entretien individuel	Comprendre en profondeur	Riche, nuancé	Long, peu de personnes	9.4
Groupe de parole (focus group)	Faire émerger représentations et idées	Dynamique de groupe, rapide	Influence des leaders, confidentialité	9.4
Analyse documentaire	Exploiter les données existantes	Rapide, fiable si la source est officielle	Données parfois anciennes ou trop générales	3.4

6.2.4 L'arbre à problèmes

L'arbre à problèmes classe les causes et les effets autour d'un problème central. Il oblige à chercher les causes profondes, sur lesquelles le projet pourra agir.

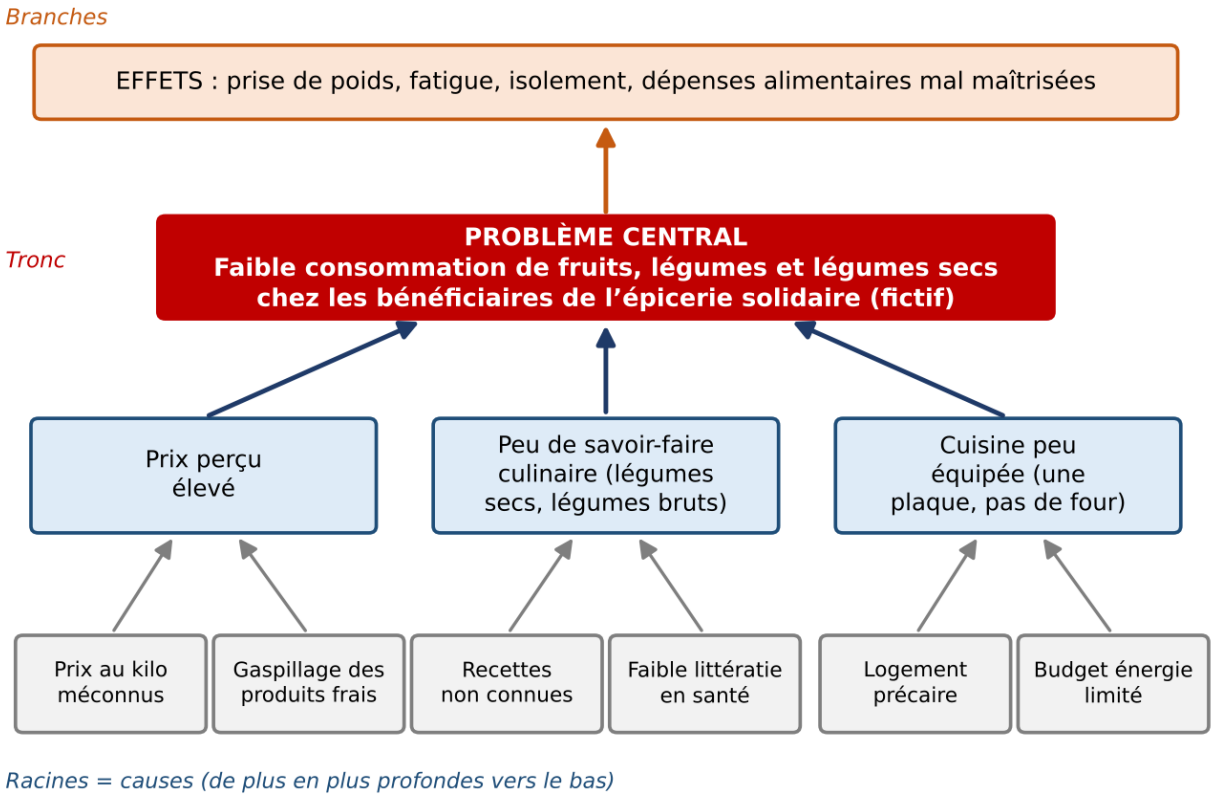


Figure 5 – Exemple d'arbre à problèmes (données fictives)

Méthode – Construire l'arbre en 5 étapes

1. Écrivez le problème central en une phrase précise : qui, quoi, où (le tronc).
2. Demandez « pourquoi ? » : chaque réponse est une cause directe (les racines).
3. Redemandez « pourquoi ? » pour chaque cause : ce sont les causes profondes.
4. Demandez « et alors ? » : chaque réponse est un effet (les branches).
5. Faites relire l'arbre par le tuteur et, si possible, par deux ou trois personnes du public.

Astuce de stagiaire – Du problème à l'objectif

Chaque cause, retournée en positif, devient un objectif possible. « Peu de savoir-faire culinaire » devient « Les participants savent cuisiner 3 recettes de légumes secs ». C'est ce qui garantit le lien entre diagnostic et objectifs, que le jury vérifie.

6.3 Étape 2 : choisir les priorités et fixer les objectifs

6.3.1 La grille de priorisation

On ne peut pas tout traiter en six semaines. La grille de priorisation compare les problèmes selon des critères notés, ici de 1 (faible) à 3 (fort).

Critère	A. Faible consommation de légumes et légumes secs	B. Boissons sucrées chez les enfants	C. Repas solitaires des seniors
Ampleur (nombre de personnes concernées)	3	2	2
Gravité pour la santé	2	2	3
Demande du public	3	1	2
Faisabilité en stage (temps, lieu, budget)	3	2	1
Cohérence avec les plans (PNNS 5, CLS)	3	3	2
Total sur 15	14	10	10

Le problème A est retenu (14 sur 15). Les problèmes B et C sont notés dans le dossier comme pistes pour plus tard. La grille et ses notes sont discutées et validées avec le tuteur.

6.3.2 Les trois niveaux d'objectifs

Niveau	Définition	Horizon	Formulation
Objectif général	Le changement de santé visé, auquel le projet contribue	Long terme	« Contribuer à améliorer… »
Objectifs spécifiques	Ce que le public saura, saura faire ou fera à la fin du projet	Moyen terme	« Les participants sont capables de… »
Objectifs opérationnels	Les actions concrètes que l'équipe réalise	Court terme	« Réaliser 4 ateliers… », « Remettre un livret… »

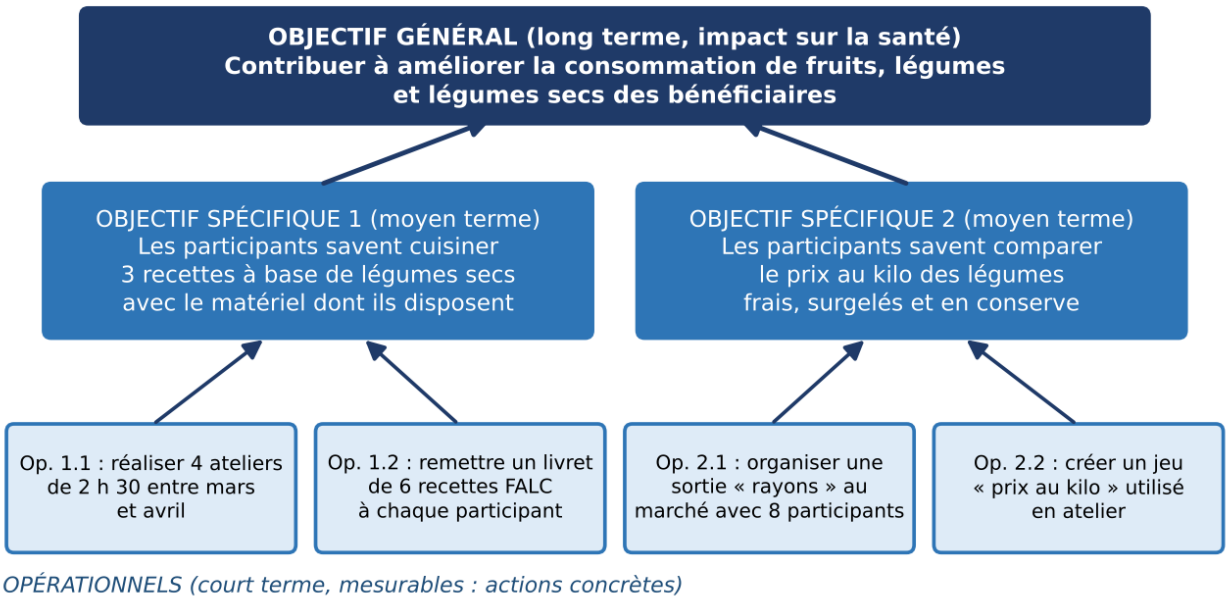


Figure 6 – Arbre des objectifs du projet fictif des Tilleuls

6.3.3 La méthode SMART

Un objectif spécifique ou opérationnel est SMART quand il est :

Lettre	Sens	Question de contrôle
S	Spécifique	Est-il précis : qui, quoi, où ?
M	Mesurable	Peut-on dire, avec un chiffre, s'il est atteint ?
A	Acceptable (ou atteignable)	Le public et la structure sont-ils d'accord ? Est-ce réaliste ?

Lettre	Sens	Question de contrôle
R	Réaliste (ou pertinent)	Les moyens suffisent-ils ? Est-il lié au diagnostic ?
T	Temporellement défini	Avant quelle date ?

Exemple – Un objectif reformulé

Avant : « Sensibiliser les familles à l'alimentation. » Ni mesurable, ni daté, « sensibiliser » ne dit pas ce qui change.

Après : « À la fin du cycle de 4 ateliers (avril 2027), au moins 7 des 10 participants inscrits savent réaliser seuls une recette à base de légumes secs avec le matériel dont ils disposent. »

Astuce de stagiaire – Les verbes à utiliser et à éviter

À utiliser : citer, nommer, comparer, calculer, choisir, préparer, réaliser, lire une étiquette, composer un menu.

À éviter : sensibiliser, connaître, comprendre, prendre conscience, savoir (seuls), car ils ne se mesurent pas.

6.4 Étape 3 : concevoir le projet

6.4.1 La fiche projet

La fiche projet résume tout le projet sur une ou deux pages. Elle sert à le présenter au tuteur, aux partenaires et aux financeurs.

Rubrique	Contenu
Titre	Court, positif, compréhensible par le public
Porteur et partenaires	Structure, stagiaire, tuteur, partenaires et leur rôle
Contexte et constat	5 lignes de diagnostic avec 2 ou 3 chiffres sourcés
Public	Qui, combien, comment il est mobilisé
Objectifs	Général, spécifiques, opérationnels
Actions	Liste des actions, dates, lieux, durée
Moyens	Humains, matériels, financiers
Budget	Tableau équilibré
Calendrier	Gantt
Communication	Plan de communication
Évaluation	Indicateurs, outils, dates
Éthique	Consentement, anonymat, droit à l'image, RGPD

6.4.2 Le plan d'action

Action	Objectif visé	Qui	Quand	Où	Moyens	Indicateur
Atelier 1 : lentilles corail	OS 1, Op 1.1	Stagiaire + animatrice	Mardi 9 mars, 14 h-16 h 30	Cuisine du centre	Denrées, fiche recette	Présents / inscrits
Sortie marché	OS 2, Op 2.1	Stagiaire + bénévole	Samedi 13 mars, 9 h 30-11 h 30	Marché du quartier	Grille de relevé de prix	Nombre de prix relevés
Livret de 6 recettes	OS 1, Op 1.2	Stagiaire	Remis le 6 avril	–	Impression	Livrets remis / inscrits

6.4.3 Le calendrier : diagramme de Gantt

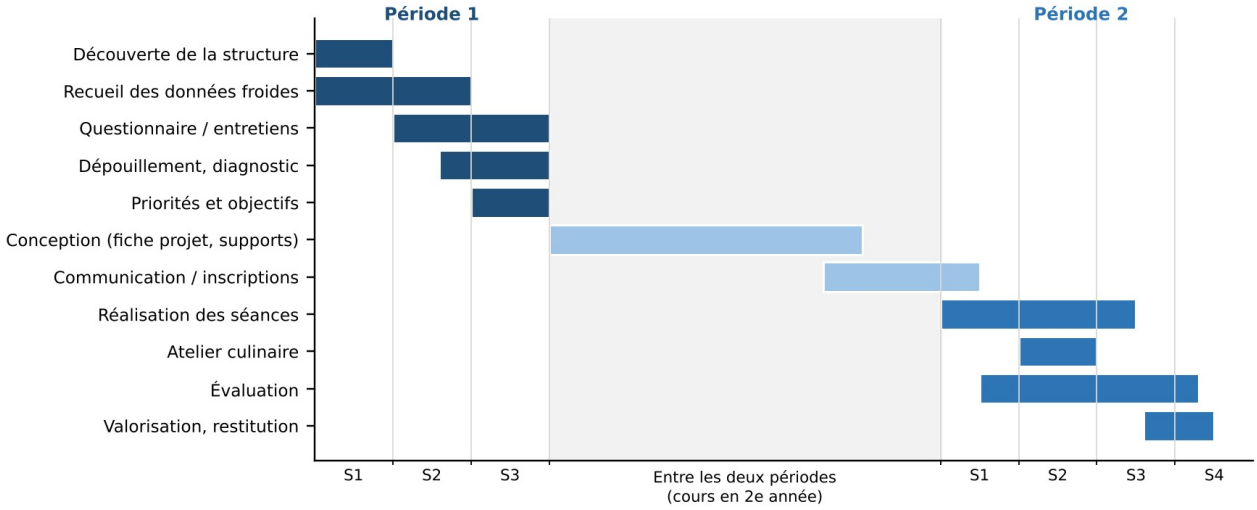


Figure 7 – Exemple de diagramme de Gantt sur l'ensemble du stage

Astuce de stagiaire – Construire un Gantt utile

Partez de la date fixe (le dernier atelier, la restitution) et remontez le temps. Ajoutez une marge d'une semaine avant chaque échéance importante. Faites apparaître les jalons : validation par le tuteur, impression des supports, réservation de la salle.

6.4.4 Le budget

Un budget prévisionnel est présenté en deux colonnes : les charges (ce que coûte le projet) et les produits (qui paie). Il est toujours équilibré : total des charges = total des produits.

Les contributions en nature (salle prêtée, temps des bénévoles et des salariés) se valorisent : elles apparaissent en charges (compte 86) et en produits (compte 87) pour le même montant. Elles montrent la valeur réelle du projet sans changer la dépense.

Charges	Montant	Produits	Montant
Denrées : 4 ateliers × 12 personnes × 1,10 €	52,80 €	Budget animation du centre social	108,80 €
12 boîtes de transport réutilisables × 2,50 €	30,00 €		
Impression de 12 livrets × 1,50 €	18,00 €		
Impression de 10 affiches A3 × 0,80 €	8,00 €		
Sous-total des dépenses	108,80 €	Sous-total des recettes	108,80 €
Compte 86 : mise à disposition de la cuisine, 4 × 3 h × 15 €	180,00 €	Compte 87 : prestations en nature	420,00 €
Compte 86 : temps de l'animatrice, 4 × 3 h × 20 €	240,00 €		
Total des charges	528,80 €	Total des produits	528,80 €

Calcul posé – Le coût par participant (budget fictif ci-dessus, 10 participants)

Coût réel en dépenses : 108,80 / 10 = 10,88 € par participant pour tout le cycle.

Coût valorisé, contributions en nature comprises : 528,80 / 10 = 52,88 € par participant.

Coût des denrées par portion : 1,10 €, soit le seuil que l'on s'est fixé pour rester proche du budget des familles.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes dans le budget

- Un budget non équilibré.
- Le salaire du stagiaire compté comme une charge (le stagiaire n'est pas rémunéré en général ; une gratification éventuelle n'est pas une dépense du projet).
- Des prix inventés : relevez les prix réels dans un magasin du quartier et notez la date du relevé.

6.4.5 Le plan de communication

Cible	Message	Support	Date	Responsable
Familles du centre social	« Des recettes faciles à moins de 1,50 € la portion : venez cuisiner avec nous ! »	Affiche FALC, flyer, annonce orale à l'accueil	3 semaines avant	Stagiaire, accueil
Équipe du centre	Objectifs, dates, besoins en aide	Réunion d'équipe, courriel	1 mois avant	Stagiaire, tuteur
Partenaires (épicerie solidaire, PMI)	Invitation à orienter des familles	Courriel, appel	1 mois avant	Tuteur
Élus, financeurs	Bilan et résultats	Note de 2 pages, restitution	À la fin	Tuteur, stagiaire

6.4.6 Le conducteur de séance

Le conducteur est le script minuté de chaque séance. Il permet à quelqu'un d'autre de refaire la séance après votre départ.

Horaire	Durée	Étape	Contenu et consignes	Matériel	Animateur
14 h 00	15 min	Accueil	Lavage des mains, tour de prénoms, règles du groupe, recueil des attentes	Badges, savon	Stagiaire
14 h 15	15 min	Questionnaire avant	Questionnaire de connaissances anonyme (5 questions, avec code)	Questionnaires, stylos	Animatrice
14 h 30	75 min	Préparation	Démonstration puis réalisation en binômes de la recette	Fiches recettes, denrées	Les deux
15 h 45	30 min	Dégustation et échange	Goût, coût de la portion, idées pour refaire à la maison	Assiettes, tableau	Stagiaire
16 h 15	15 min	Clôture	Questionnaire de satisfaction, engagement facultatif, rangement	Fiches d'évaluation	Les deux

6.5 Étape 4 : la mise en œuvre

Avant chaque séance	Pendant	Après
Relire le conducteur, vérifier les inscriptions, faire les courses avec le ticket de caisse, préparer le matériel, vérifier les allergies déclarées	Respecter le timing, observer, noter les réactions, faire participer chacun, appliquer les règles d'hygiène	Ranger, saisir les données le jour même, écrire un compte rendu court, noter les écarts et les ajustements

À retenir – Le pilotage

Piloter, c'est comparer chaque semaine le prévu et le réalisé (dates, présences, dépenses) et décider des

ajustements avec le tuteur. Ces ajustements, expliqués, sont une preuve de compétence pour le jury.

6.6 Étape 5 : l'évaluation

6.6.1 Les trois types d'évaluation

Type	Question	Exemples d'indicateurs
Évaluation de processus (ou de réalisation)	Les actions ont-elles été réalisées comme prévu ?	Nombre d'ateliers réalisés / prévus, taux de participation, dépenses réelles / prévues, satisfaction
Évaluation de résultat	Les objectifs spécifiques sont-ils atteints ?	Évolution du score de connaissances, nombre de participants qui ont refait une recette
Évaluation d'impact	Quels effets sur la santé à long terme, prévus ou non ?	Rarement mesurable en stage : on dit pourquoi et comment on pourrait le mesurer

Définition – Indicateur

Donnée chiffrée ou observable qui permet de dire si un objectif est atteint. Un bon indicateur a une définition précise, un mode de calcul, une source, une valeur cible et une date de mesure.

6.6.2 Exemple de tableau de bord (données fictives des Tilleuls)

Indicateur	Calcul	Cible	Résultat	Atteint ?
Ateliers réalisés	4 réalisés / 4 prévus	100 %	100 %	Oui
Taux de présence	(10 + 9 + 11 + 8) / (4 × 12 inscrits) = 38 / 48	75 %	79,2 %	Oui
Satisfaction	30 fiches « satisfait » ou « très satisfait » sur 34 fiches rendues	80 %	88,2 %	Oui
Score de connaissances (sur 10, 10 participants appariés)	Moyenne avant 4,6 ; moyenne après 7,3	+ 2 points	+ 2,7 points	Oui
Recette refaite à la maison à 1 mois	6 répondants sur 9	7 sur 10 inscrits	6 sur 9 répondants	Partiellement
Dépenses	104,30 € dépensés / 108,80 € prévus	≤ 100 %	95,9 %	Oui

Calcul posé – Vérification des calculs du tableau de bord

Présence moyenne par atelier : 38 / 4 = 9,5 participants.

Évolution du score : 7,3 − 4,6 = 2,7 points, soit une hausse relative de 2,7 / 4,6 × 100 = 58,7 %.

Dépenses : 104,30 / 108,80 × 100 = 95,9 % du prévu.

6.6.3 Analyser les résultats et leurs limites

Un résultat chiffré doit être interprété : pourquoi ce chiffre ? Qu'est-ce qui a aidé ou freiné ? Ensuite, on énonce honnêtement les limites.

Limite fréquente	Ce qu'elle signifie	Comment l'écrire
Petit effectif	Les pourcentages sont fragiles	« Avec 10 participants, ces résultats ne peuvent pas être généralisés. »
Données déclaratives	Les personnes peuvent surestimer leurs bons comportements (biais de désirabilité sociale)	« Les participants ont déclaré… ; ce n'est pas une mesure directe. »
Pas de groupe témoin	On ne sait pas si le changement vient de l'atelier	« D'autres facteurs ont pu jouer. »
Mesure à court terme	On ne sait pas si le changement dure	« Une mesure à 6 mois serait nécessaire. »
Perdus de vue	Ceux qui ne répondent plus sont peut-être ceux qui ont le moins changé	« 1 inscrit sur 10 n'a pas répondu à 1 mois. »

6.7 Étape 6 : la valorisation et la capitalisation

Action	Exemple
Restituer les résultats	Présentation de 15 minutes à l'équipe et aux participants, avec le tableau de bord
Transmettre	Classeur ou dossier numérique : conducteurs, fiches recettes, outils d'évaluation, liste des partenaires
Pérenniser	Former l'animatrice ou des habitants relais pour continuer les ateliers
Faire connaître	Article dans le journal du centre ou de la commune (avec autorisations)
S'auto-évaluer	Grille d'auto-évaluation par compétence, 3 points forts, 3 axes de progrès

Préparer l'oral – Pistes de réponse sur la pérennité

« Le projet continue sans moi parce que l'animatrice a coanimé les quatre ateliers et dispose des conducteurs et des fiches recettes. Le centre social a inscrit deux ateliers par trimestre dans son programme. Le coût en denrées reste faible, 1,10 € par portion. »

Partie 7 – Communiquer et animer (C3.5)

7.1 Le schéma de la communication

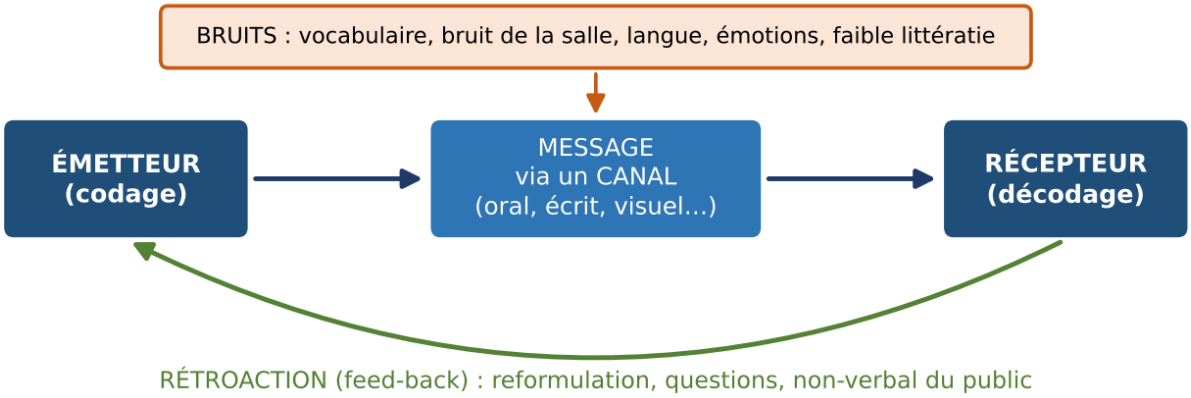


Figure 8 – Le schéma de la communication et ses obstacles

Chaque message passe par un émetteur, un canal et un récepteur. Les « bruits » le déforment : mots techniques, salle bruyante, langue, émotions, faible littératie. La rétroaction (le retour du public) permet de vérifier que le message est passé.

7.2 Les techniques d'écoute active

Technique	Comment	Exemple
Questions ouvertes	Commencer par « comment », « qu'est-ce que », « racontez-moi »	« Comment se passent les repas chez vous en semaine ? »
Reformulation	Redire avec ses mots ce que la personne a dit	« Si je comprends bien, le soir vous manquez de temps pour cuisiner. »
Relance	Encourager à continuer	« C'est-à-dire ? », « Et ensuite ? »
Silence	Laisser 3 à 5 secondes avant de reprendre	–
Synthèse	Résumer les idées principales à la fin	« Nous avons parlé de trois freins : le prix, le temps et les goûts des enfants. »
Valorisation	Reconnaître un savoir ou un effort	« Vous connaissez déjà beaucoup de recettes de votre région, c'est une vraie ressource. »

Définition – Attitudes de Porter

Elias Porter (1950) décrit six attitudes spontanées face à quelqu'un qui parle : évaluation (juger), interprétation, soutien, investigation (enquêter), solution immédiate, compréhension (reformuler). L'attitude de compréhension est celle qui aide le plus la personne à s'exprimer ; le jugement et la solution immédiate la bloquent.

7.3 Animer un groupe

7.3.1 Les règles du groupe

Posez-les dès le début, au tableau, et faites-les valider par le groupe : on écoute celui qui parle ; on ne juge pas ; ce qui se dit ici reste ici ; on a le droit de ne pas goûter ; les téléphones en silencieux.

7.3.2 Les techniques d'animation

Technique	Déroulement	Durée	Utile pour
Tour de table	Chacun dit son prénom et une chose (plat préféré, attente)	10 min	Accueillir, briser la glace
Brainstorming	Toutes les idées sont notées sans critique, puis classées	10-15 min	Recueillir des représentations
Photolangage	Chacun choisit une photo et explique pourquoi	20-30 min	Faire parler de sujets intimes (repas, corps)
Abaque de Régnier	On réagit à des affirmations avec des cartes de couleur (d'accord… pas d'accord) puis on débat	20-30 min	Faire émerger les opinions, débattre
Jeu du vrai ou faux	Affirmations sur les idées reçues	15 min	Corriger les fausses croyances sans humilier
Jeu de tri	Classer des aliments (familles, prix, sucre)	15 min	Apprendre en manipulant
Démonstration puis pratique	L'animateur montre, puis chacun fait	Variable	Gestes culinaires
Mise en situation	Simuler une situation réelle (courses avec 10 €)	20-30 min	Transférer dans la vie quotidienne
Quiz avant-après	Mêmes questions au début et à la fin	2 × 5 min	Évaluer les connaissances

Astuce de stagiaire – Organiser la séance en entonnoir

Partir du vécu des participants (ce qu'ils font), puis apporter des connaissances, puis pratiquer, puis faire le lien avec la vie quotidienne. Ne commencez jamais par un exposé théorique.

7.3.3 Gérer les situations difficiles

Situation	Réaction possible
Un participant monopolise la parole	« Merci, c'est intéressant ; j'aimerais entendre aussi ceux qui n'ont pas encore parlé. »
Un participant conteste tout	Accueillir l'avis, demander au groupe ce qu'il en pense, rester factuel, proposer d'en parler après
Personne ne parle	Travail en binômes puis mise en commun, questions plus fermées, vote à main levée
Une question à laquelle vous ne savez pas répondre	« Je ne sais pas ; je vérifie et je vous réponds la prochaine fois. » Et vous le faites.
Un sujet dépasse votre rôle (maladie, détresse)	Écouter, ne pas donner de conseil médical, orienter vers le bon professionnel, prévenir le tuteur
Un conflit entre participants	Rappeler les règles, recentrer sur l'activité, en parler au tuteur

7.4 Concevoir un support

Méthode – Les règles d'un bon support (affiche, flyer, diaporama, livret)

- Un seul message principal, lisible à 2 mètres pour une affiche.
- Qui, quoi, où, quand, comment s'inscrire, gratuité : toujours présents sur une affiche d'invitation.
- Images libres de droits ou faites par vous, pas d'images trouvées sur internet sans licence.
- Logos de la structure et des partenaires avec leur accord.
- Relecture orthographique, puis test auprès de 2 ou 3 personnes du public.

- Messages positifs : « Ajoutez des légumes secs » plutôt que « Arrêtez la viande ».
- Pas de marque commerciale mise en avant.

7.5 Communiquer avec les professionnels

Écrit professionnel	Contenu	Longueur
Courriel	Objet clair, formule de politesse, une demande par courriel, signature avec statut et structure	10 lignes
Compte rendu de réunion	Date, présents, ordre du jour, décisions, qui fait quoi pour quand	1 page
Note de synthèse	Contexte, constat, propositions, demande de décision	1 à 2 pages
Point hebdomadaire au tuteur	Réalisé, prévu, difficultés, décisions à prendre	Demi-page

Modèle à recopier – Courriel de demande de rendez-vous à un partenaire

Objet : Projet nutrition au centre social des Tilleuls – demande de rendez-vous

Madame,

Je suis étudiant(e) en BTS Diététique et nutrition, en stage au centre social des Tilleuls sous la responsabilité de [nom du tuteur]. Nous préparons des ateliers cuisine pour les familles du quartier sur le thème des repas à petit budget.

Votre épicerie solidaire accueille une partie de ces familles. Pourriez-vous m'accorder un entretien de 30 minutes pour connaître vos besoins et voir si une collaboration est possible ? Je suis disponible les [jours] entre [heures].

Je vous remercie par avance. Bien cordialement,

[Prénom Nom], stagiaire BTS Diététique et nutrition, [structure], [téléphone de la structure]

7.6 Prendre la parole en public

Avant	Pendant	Après
Répéter à voix haute avec un chronomètre ; préparer 3 messages clés ; arriver 30 minutes en avance	Regarder tout le monde, parler lentement, faire des pauses, se déplacer, poser des questions au public	Demander un retour au tuteur, noter 1 point fort et 1 point à travailler

Astuce de stagiaire – Contre le trac

Respirez lentement (inspirez 4 secondes, expirez 6 secondes) pendant une minute avant de commencer. Apprenez par cœur seulement vos deux premières phrases : après, le contenu vient tout seul.

Partie 8 – Les ateliers culinaires (C3.2)

8.1 Pourquoi un atelier culinaire

L'atelier culinaire est un outil d'éducation pour la santé : on apprend en faisant, on partage un moment agréable, on repart avec une recette que l'on peut refaire. Il agit sur les compétences (savoir-faire), la confiance en soi et le lien social.

À retenir – Un atelier n'est pas un cours de cuisine

Un cours de cuisine apprend une recette. Un atelier de santé publique a un objectif de santé lié au diagnostic, un public défini, des contraintes réelles (budget, matériel, culture) et une évaluation.

8.2 Concevoir l'atelier : la fiche atelier

Rubrique	Exemple (fictif, Tilleuls, atelier 1)
Titre	« Les lentilles, c'est facile ! »
Public, nombre	10 adultes de familles du centre social, avec 2 animateurs
Objectif spécifique visé	OS 1 : savoir cuisiner 3 recettes à base de légumes secs
Objectifs de la séance	Réaliser un dahl de lentilles corail en binôme ; calculer le coût d'une portion ; citer 2 façons d'utiliser des légumes secs
Contraintes	Plaque électrique seulement, 2 h 30, budget denrées 1,10 € par personne, 1 personne allergique au céleri
Recette(s)	Dahl de lentilles corail et riz (fiche technique en 8.3)
Déroulement	Conducteur de séance (6.4.6)
Matériel	3 plaques, 3 casseroles, planches, couteaux, balance, verres doseurs
Hygiène et sécurité	Lavage des mains, tenue, chaîne du froid, allergènes affichés
Évaluation	Quiz avant-après, fiche de satisfaction, observation des gestes
Éco-gestes	Légumes de saison, épluchures au compost, eau de cuisson réutilisée, boîtes réutilisables

8.3 La fiche technique et le calcul du coût

La fiche technique décrit une recette de façon standardisée : ingrédients et quantités, coût, étapes, temps, matériel, points critiques d'hygiène, allergènes.

Calcul posé – Fiche technique : dahl de lentilles corail et riz, 6 portions (prix fictifs pour l'exemple)

Ingrédient	Quantité	Prix d'achat	Coût
Lentilles corail	300 g	3,20 € le kg	0,96 €
Oignon	150 g	2,00 € le kg	0,30 €
Carottes	300 g	1,50 € le kg	0,45 €
Tomates concassées en conserve	400 g (1 boîte)	0,90 € la boîte	0,90 €
Lait de coco	200 mL	1,60 € les 400 mL	0,80 €
Huile de colza	20 g	forfait	0,05 €
Curry, cumin, sel	quelques grammes	forfait	0,15 €
Riz	300 g	1,80 € le kg	0,54 €

Ingrédient	Quantité	Prix d'achat	Coût
Total pour 6 portions			4,15 €

Coût par portion = 4,15 / 6 = 0,69 € (0,6917 arrondi au centime).

Méthode – Calculer le coût d'un ingrédient

Coût = quantité utilisée × prix à l'unité de mesure. Exemple : 300 g de lentilles à 3,20 € le kg : 0,300 kg × 3,20 € = 0,96 €.

Pour un produit acheté entier (légumes à éplucher), utilisez le poids brut, avant épluchage. Le poids net, après épluchage, sert au calcul nutritionnel. Le rapport poids net / poids brut est le rendement.

8.4 L'analyse nutritionnelle d'une recette

Méthode – Les étapes

1. Pour chaque ingrédient, relevez dans la table Ciqual (Anses) l'énergie et les nutriments pour 100 g de l'aliment dans l'état où il est pesé (cru, en conserve…).
2. Multipliez par la quantité nette utilisée divisée par 100.
3. Additionnez, puis divisez par le nombre de portions.
4. Calculez la part de l'énergie apportée par chaque macronutriment : protéines × 4 kcal, glucides × 4 kcal, lipides × 9 kcal (et fibres × 2 kcal si on les compte).
5. Comparez à un repère (par exemple la part d'un repas dans les besoins de la journée) et concluez.

Calcul posé – Exemple d'application avec des valeurs arrondies (à remplacer par les valeurs Ciqual de la version en vigueur)

Ingrédient (quantité)	Énergie pour 100 g	Protéines pour 100 g	Énergie apportée	Protéines apportées
Lentilles corail crues (300 g)	340 kcal	24 g	1 020 kcal	72,0 g
Riz cru (300 g)	350 kcal	7 g	1 050 kcal	21,0 g
Carottes (300 g)	36 kcal	0,8 g	108 kcal	2,4 g
Oignon (150 g)	40 kcal	1,2 g	60 kcal	1,8 g
Tomates en conserve (400 g)	25 kcal	1,2 g	100 kcal	4,8 g
Lait de coco (200 g)	180 kcal	1,5 g	360 kcal	3,0 g
Huile de colza (20 g)	900 kcal	0 g	180 kcal	0,0 g
Total (6 portions)			2 878 kcal	105,0 g

Par portion : 2 878 / 6 = 479,7 kcal, arrondi à 480 kcal ; 105,0 / 6 = 17,5 g de protéines.

Part de l'énergie apportée par les protéines : 17,5 × 4 / 479,7 × 100 = 14,6 %.

L'association d'une légumineuse et d'une céréale améliore la complémentarité des acides aminés : c'est un plat principal végétarien complet du point de vue protéique.

Attention – Valeurs d'exemple

Les valeurs nutritionnelles ci-dessus sont des ordres de grandeur arrondis pour apprendre le calcul. Dans votre dossier, utilisez les valeurs exactes de la table Ciqual et notez sa version et la date de consultation.

8.5 Ce qui se passe dans la casserole : les transformations physico-chimiques

Le jury peut demander d'expliquer un phénomène observé pendant l'atelier.

Phénomène	Ce qui se passe	Exemple en atelier
Gélatinisation de l'amidon (empois)	Dans l'eau chaude, les grains d'amidon gonflent et la préparation épaissit	Béchamel, riz, lentilles corail qui « fondent »
Rétrogradation de l'amidon	En refroidissant, l'amidon se réorganise : texture plus ferme, pain rassis	Riz refroidi, pain de la veille
Coagulation des protéines	La chaleur ou l'acide modifient les protéines qui se solidifient	Œuf cuit, flan, poisson mariné au citron
Réaction de Maillard	Sucres et protéines réagissent à haute température : brunissement, arômes	Pain grillé, viande saisie, oignons dorés
Caramélisation	Le sucre seul chauffé brunit	Caramel, oignons confits
Émulsion	Deux liquides non miscibles dispersés grâce à un émulsifiant	Vinaigrette, mayonnaise (lécithine du jaune d'œuf)
Mousse et foisonnement	De l'air piégé dans un liquide	Blancs en neige, crème fouettée, aquafaba (eau de pois chiches)
Gélification	Un réseau retient l'eau et forme un gel	Gélatine, agar-agar, pectine des confitures
Brunissement enzymatique	Des enzymes oxydent les fruits coupés	Pomme coupée qui brunit (le citron le limite)
Pertes vitaminiques	Vitamines hydrosolubles et sensibles à la chaleur (vitamine C, B9) perdues dans l'eau de cuisson	Préférer la cuisson vapeur, peu d'eau, cuisson courte
Trempage et cuisson des légumes secs	Réhydratation, diminution de certains facteurs antinutritionnels et des composés responsables des flatulences	Pois chiches trempés une nuit, eau de trempage jetée

8.6 Adapter l'atelier

8.6.1 Adaptations culturelles et de budget

Contrainte	Adaptation
Pratiques religieuses	Demander, ne jamais supposer ; proposer des protéines végétales ou du poisson ; vérifier les gélatines
Végétarisme, végétalisme	Associer légumineuses et céréales ; en végétalien, la vitamine B12 nécessite une supplémentation, à signaler sans faire de prescription
Petit budget	Légumes secs, œufs, surgelés nature, conserves de légumes, fruits et légumes de saison, marques de distributeur, achat en vrac
Peu d'équipement	Recettes à une casserole, sans four, sans robot
Peu de temps	Recettes en 15 à 20 minutes, cuisson en grande quantité puis congélation
Culture d'origine	Partir des plats que les participants connaissent et les faire évoluer

8.6.2 Adaptations thérapeutiques (dans le cadre de la prévention)

Situation	Adaptation en atelier
Maladie cœliaque	Aucune trace de gluten : matériel et plan de travail dédiés ou nettoyés, ingrédients vérifiés (blé, seigle, orge, épeautre, avoine non certifiée)
Hypertension, alimentation pauvre en sel	Herbes, épices, agrumes ; pas de bouillon cube ni de sauce soja
Diabète	Pas d'aliment interdit : on travaille l'équilibre du repas, les fibres, les portions de féculents
Personne âgée à risque de dénutrition	Enrichir (poudre de lait, œuf, fromage râpé, huile), privilégier le plaisir, pas de restriction
Troubles de la déglutition	Textures adaptées selon les niveaux IDDSI, sur avis du médecin ou de l'orthophoniste

Définition – IDDSI

International Dysphagia Diet Standardisation Initiative : cadre international qui décrit les textures en 8 niveaux, de 0 à 7. Boissons : 0 fluide, 1 très légèrement épais, 2 légèrement épais, 3 modérément épais, 4 très épais. Aliments : 3 liquéfié, 4 mixé lisse, 5 haché et lubrifié, 6 tendre et en petits morceaux, 7 normal (avec une variante « facile à mâcher »). Des tests simples (écoulement à la seringue, test à la fourchette) permettent de vérifier le niveau.

Définition – DADFMS

Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (règlement européen 609/2013) sont des produits conçus pour des patients, par exemple les compléments nutritionnels oraux. Elles s'utilisent sous contrôle médical. En atelier de prévention, on peut les montrer ou les intégrer dans une recette pour un public qui en a déjà sur prescription, jamais les recommander soi-même.

8.7 Hygiène et sécurité en atelier

À retenir – Les températures à connaître

- Réfrigérateur : 4 °C au maximum (vérifiez avec un thermomètre).
- Liaison chaude : 63 °C au minimum jusqu'au service.
- Refroidissement rapide d'un plat cuit : passer de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures.
- Remise en température : atteindre 63 °C à cœur en moins d'une heure.
- Viande hachée pour un public sensible (enfants, personnes âgées) : cuite à cœur, 70 °C.

Règle	En pratique
Hygiène des mains	Lavage au savon 30 secondes à l'arrivée, après être passé aux toilettes, après avoir touché des aliments crus, la poubelle, son téléphone
Tenue	Tablier propre, cheveux attachés et couverts, bijoux retirés, plaie protégée par un pansement et un gant
Marche en avant	Les produits propres ne croisent pas les produits sales ; en cuisine pédagogique, on l'organise dans le temps : tâches sales d'abord, nettoyage, puis tâches propres
Chaîne du froid	Courses juste avant l'atelier, sac isotherme, produits frais au réfrigérateur dès l'arrivée
Œufs	Ne pas laver les œufs (l'eau abîme la cuticule protectrice) ; pas de préparation à base d'œuf cru pour les publics fragiles

Règle	En pratique
Publics fragiles	Femmes enceintes, jeunes enfants, personnes âgées, personnes immunodéprimées : pas de lait cru, pas de fromage au lait cru, pas de viande ou de poisson crus ou peu cuits
Restes	Ne pas faire repartir de préparation sans boîte propre et sans conseil de conservation (réfrigérateur, à consommer dans les 24 heures)
Sécurité	Couteaux adaptés à l'âge, manches de casserole tournés vers l'intérieur, trousse de secours, consignes incendie connues

8.7.1 Les 14 allergènes à déclaration obligatoire

Le règlement européen INCO (règlement 1169/2011) impose d'informer sur 14 allergènes, y compris pour les denrées non préemballées.

Céréales contenant du gluten	Crustacés	Œufs
Poissons	Arachides	Soja
Lait	Fruits à coque	Céleri
Moutarde	Graines de sésame	Anhydride sulfureux et sulfites (au-delà de 10 mg/kg ou 10 mg/L)
Lupin	Mollusques	

Méthode – Gérer les allergies en atelier

1. Demandez les allergies et intolérances à l'inscription (sans demander de diagnostic détaillé).
2. Affichez les allergènes de chaque recette.
3. Lisez les étiquettes de chaque produit acheté (« peut contenir des traces de… »).
4. Remplacez l'ingrédient ou adaptez la recette pour toute la table : c'est plus simple et plus sûr qu'une portion à part.
5. Prévoyez le numéro du SAMU (15) ou le numéro d'urgence européen (112) et sachez qui contacter dans la structure.

8.7.2 La méthode HACCP en bref

L'HACCP (analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise) repose sur 7 principes : analyser les dangers, déterminer les points critiques, fixer les limites critiques, surveiller, prévoir les actions correctives, vérifier, documenter. En restauration collective, les plats témoins sont conservés 5 jours au moins au froid (arrêté du 21 décembre 2009). En atelier pédagogique, suivez les règles de la structure et notez au minimum les températures des produits frais et les dates limites.

8.8 Analyse sensorielle et dégustation

Sens	Ce que l'on décrit	Vocabulaire simple
Vue	Couleur, forme, brillance	Doré, coloré, terne, appétissant
Odorat	Odeurs (nez) et arômes (en bouche, par la voie rétronasale)	Épicé, fruité, grillé
Goût	Les cinq saveurs : sucré, salé, acide, amer, umami	Trop salé, pas assez acide
Toucher en bouche	Texture, température, piquant	Fondant, croquant, crémeux, granuleux
Ouïe	Bruits à la mastication	Croustillant

Une grille de dégustation avec une échelle de 1 à 5 (ou des visages pour les enfants) permet d'évaluer l'acceptabilité d'une recette. Pour les enfants, rappelez que la néophobie alimentaire est normale : il faut souvent proposer un aliment de nombreuses fois avant qu'il soit accepté.

8.9 Éco-gestes et alimentation durable

Domaine	Geste en atelier
Choix des produits	Fruits et légumes de saison, produits locaux, part plus grande de végétal, labels de qualité, vrac
Gaspillage	Quantités ajustées au nombre de participants, recettes avec les restes et les fanes, partage des restes en boîtes
Déchets	Tri, compost, contenants réutilisables, pas de vaisselle jetable
Énergie et eau	Couvercle sur les casseroles, cuisson groupée, eau de cuisson réutilisée pour une soupe, vaisselle en bassine

Préparer l'oral – Question fréquente du jury

« Quels gestes éco-responsables avez-vous mis en place ? » Citez trois gestes précis et réellement faits, avec un chiffre si possible : « Nous avons cuisiné uniquement des légumes de saison, nous avons utilisé 12 boîtes réutilisables au lieu de barquettes jetables, et les épluchures sont allées au compost du jardin partagé. »

8.10 L'atelier de l'épreuve E5 (temps 2, 3 heures)

Temps conseillé	Étape
0 h 00 – 0 h 20	Lire le contexte imposé : public, besoins, contraintes (matériel, budget, durée, allergies, culture) ; formuler les objectifs de l'atelier
0 h 20 – 0 h 45	Choisir la recette, écrire la fiche technique (quantités, coût, allergènes) et le déroulement de l'atelier
0 h 45 – 2 h 15	Réaliser la préparation en respectant l'hygiène, en expliquant ce que vous feriez avec le public (gestes, messages, questions)
2 h 15 – 2 h 40	Dresser, déguster, analyser (goût, coût, intérêt nutritionnel, adaptation au public)
2 h 40 – 3 h 00	Nettoyer et ranger ; préparer l'évaluation de l'atelier (indicateurs, outil)

Astuce de stagiaire – Préparez une banque de 10 recettes

Avant l'épreuve, préparez et testez 10 recettes simples, peu chères et adaptables (sans four, sans gluten, texture modifiée, pour enfants, pour personnes âgées). Pour chacune, connaissez le coût par portion, les allergènes et un message de santé.

Partie 9 – Épidémiologie, enquêtes et traitement des données (C3.3)

9.1 Les types d'études

Type	Question	Déroulement	Exemple
Descriptive transversale	Quelle est la situation à un moment donné ?	Photographie d'une population à une date	Enquête sur le petit-déjeuner des élèves de 6e en octobre
Cohorte (analytique)	Une exposition augmente-t-elle le risque ?	On suit dans le temps des personnes exposées et non exposées	Suivi sur 5 ans d'enfants qui prennent ou non un petit-déjeuner
Cas-témoins (analytique)	Les malades ont-ils été plus exposés ?	On compare le passé de malades (cas) et de non-malades (témoins)	Comparer la consommation de boissons sucrées d'enfants obèses et non obèses
Essai contrôlé randomisé (expérimental)	Une intervention est-elle efficace ?	Tirage au sort entre un groupe qui reçoit l'intervention et un groupe témoin	Ateliers cuisine dans 10 écoles tirées au sort, 10 écoles témoins

À retenir – Niveau de preuve

Plus une étude contrôle les biais, plus son niveau de preuve est élevé : méta-analyses et essais randomisés en haut, études de cohorte, puis cas-témoins, puis séries de cas et avis d'experts. La HAS gradue ses recommandations : grade A (preuve scientifique établie), grade B (présomption scientifique), grade C (faible niveau de preuve), et « accord d'experts » quand les données manquent.

9.2 Mesurer une association

9.2.1 Le tableau de contingence

	Malades	Non malades	Total
Exposés	a	b	a + b
Non exposés	c	d	c + d

Définition – Risque relatif (RR)

Utilisé dans les études de cohorte. RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)]. RR = 1 : pas d'association ; RR supérieur à 1 : l'exposition est associée à un risque plus élevé ; RR inférieur à 1 : l'exposition est associée à un risque plus faible (facteur protecteur).

Calcul posé – Exemple de risque relatif (données fictives)

On suit pendant 3 ans 200 enfants qui sautent souvent le petit-déjeuner (exposés) et 300 enfants qui le prennent (non exposés). 30 exposés et 24 non exposés deviennent en surpoids.

Risque chez les exposés = 30 / 200 = 0,15. Risque chez les non exposés = 24 / 300 = 0,08.

RR = 0,15 / 0,08 = 1,875, arrondi à 1,88.

Interprétation : dans cet exemple, les enfants qui sautent le petit-déjeuner ont un risque de surpoids 1,88 fois plus élevé. Une association n'est pas une preuve de cause : d'autres facteurs (revenus, sommeil) peuvent jouer.

Définition – Odds ratio (OR, rapport des cotes)

Utilisé dans les études cas-témoins. OR = (a × d) / (b × c). Il s'interprète comme le RR lorsque la maladie est rare.

Calcul posé – Exemple d'odds ratio (données fictives)

60 enfants obèses (cas) dont 40 boivent des sodas tous les jours ; 120 enfants non obèses (témoins) dont 48 boivent des sodas tous les jours.

a = 40, c = 20 (cas non exposés), b = 48, d = 72 (témoins non exposés).

OR = (40 × 72) / (48 × 20) = 2 880 / 960 = 3,0.

Interprétation : les cas ont 3 fois plus souvent été exposés aux sodas quotidiens que les témoins (en termes de cotes).

9.3 Le questionnaire

9.3.1 Construire un questionnaire en 8 étapes

1. Écrire l'objectif du questionnaire en une phrase et la liste des informations nécessaires (et seulement celles-là).
2. Choisir le mode de passation : papier, en ligne, en face à face (indispensable si la littératie est faible).
3. Rédiger les questions (10 à 15 au maximum, 10 minutes de passation).
4. Les ordonner en entonnoir : questions simples et générales d'abord, questions personnelles (âge, revenus) à la fin.
5. Écrire l'introduction : qui, pourquoi, anonymat, durée, liberté de répondre (voir 5.3).
6. Tester sur 3 à 5 personnes du public (pré-test), puis corriger les questions mal comprises.
7. Faire valider par le tuteur.
8. Préparer la grille de saisie (tableur) avant de distribuer.

9.3.2 Les types de questions

Type	Exemple	Avantage	Limite
Fermée à choix unique	« Prenez-vous un petit-déjeuner ? Oui / Non »	Facile à traiter	Pauvre
Fermée à choix multiples	« Qu'est-ce qui vous empêche de cuisiner ? (plusieurs réponses possibles) »	Plus complet	Le total dépasse 100 % : à expliquer
Échelle de Likert	« Cuisiner les légumes secs, c'est facile : tout à fait d'accord… pas du tout d'accord »	Mesure une opinion	Tendance à répondre au milieu
Échelle numérique	« De 0 à 10, à quel point êtes-vous à l'aise pour cuisiner ? »	Calcul de moyennes	Interprétation variable
Fréquence	« Combien de fois par semaine mangez-vous des légumes secs ? 0 / 1 / 2 / 3 ou plus »	Comparable aux repères	Mémoire, déclaratif
Ouverte	« Quel atelier aimeriez-vous ? »	Riche	Long à analyser

Erreurs fréquentes – Les questions mal posées

- Question double : « Mangez-vous des fruits et des légumes ? » (une personne peut manger l'un et pas

l'autre).

- Question orientée : « Ne pensez-vous pas qu'il faudrait manger plus de légumes ? »
- Mot technique : « Consommez-vous des légumineuses ? » (dire « lentilles, pois chiches, haricots secs »).
- Négation : « Ne mangez-vous jamais de poisson ? »
- Réponses qui se chevauchent : « 1 à 2 fois / 2 à 3 fois ».

9.3.3 Combien de personnes interroger ?

Pour estimer une proportion dans une grande population avec une précision donnée, on utilise : $n = z^2 \times p \times (1 - p) / e^2$, avec z = 1,96 pour une confiance de 95 %, p la proportion attendue (0,5 si on ne sait pas), e la marge d'erreur.

Calcul posé – Exemple

Avec p = 0,5 et e = 0,05 (5 points) : $n = 1{,}96^2 \times 0{,}5 \times 0{,}5 / 0{,}05^2 = 3{,}8416 \times 0{,}25 / 0{,}0025 = 384{,}16$. On arrondit toujours au-dessus : 385 personnes.

En stage, on interroge souvent 30 à 60 personnes : c'est une enquête exploratoire, non représentative. Il faut le dire dans les limites.

9.3.4 L'échantillonnage et les biais

Biais	Explication	Exemple
Biais de sélection	L'échantillon ne ressemble pas à la population	Questionnaire distribué seulement aux personnes présentes le mercredi matin
Biais de désirabilité sociale	On répond ce qui est bien vu	Les participants déclarent manger plus de légumes qu'en réalité
Biais de mémoire	On se souvient mal	« Combien de fois avez-vous mangé du poisson le mois dernier ? »
Biais de l'enquêteur	L'enquêteur influence les réponses	Ton approbateur, reformulation orientée
Non-réponse	Ceux qui ne répondent pas diffèrent de ceux qui répondent	Les personnes qui lisent mal ne rendent pas le questionnaire

9.4 Les méthodes qualitatives

Méthode	Organisation	Conseils
Entretien semi-directif	20 à 45 minutes, une personne, guide de 5 à 8 thèmes avec relances	Enregistrer seulement avec accord écrit ; sinon, prise de notes et relecture le jour même
Groupe de parole (focus group)	6 à 10 personnes, 60 à 90 minutes, un animateur et un observateur qui note	Règles du groupe, tour de parole, synthèse à la fin
Observation	Grille préparée : ce qui est observé, quand, combien de fois	Observer sans juger ; noter les faits, séparés des interprétations

Méthode – Analyser des réponses ouvertes ou des entretiens

1. Retranscrire ou relire les notes.
2. Repérer les idées qui reviennent (thèmes), par exemple « prix », « temps », « goûts des enfants ».
3. Compter dans combien d'entretiens chaque thème apparaît.
4. Choisir une ou deux citations courtes et anonymes pour illustrer chaque thème.

9.5 Les enquêtes alimentaires

Méthode	Principe	Avantages	Limites
Rappel de 24 heures	La personne décrit tout ce qu'elle a mangé et bu la veille	Rapide, peu de mémoire nécessaire	Un seul jour n'est pas représentatif
Enregistrement alimentaire (carnet sur 3 à 7 jours)	La personne note au fur et à mesure	Précis	Fatigant, modifie les habitudes
Questionnaire de fréquence	Fréquence de consommation d'une liste d'aliments	Habitudes sur une longue période	Peu précis sur les quantités
Histoire alimentaire	Entretien sur les habitudes usuelles	Complet	Long, demande un enquêteur formé

Pour estimer les quantités, on utilise des photos de portions, des mesures ménagères (cuillère, bol, verre) ou des modèles.

9.6 Saisir, traiter et présenter les données

9.6.1 La saisie

Une ligne par questionnaire (avec un numéro), une colonne par question, des codes définis à l'avance (1 = oui, 0 = non, vide = pas de réponse). Gardez le fichier de saisie sur un espace sécurisé (5.5).

9.6.2 Les indicateurs statistiques de base

Indicateur	Calcul	Usage
Effectif et pourcentage	n et n / total × 100	Variables qualitatives (oui, non)
Moyenne	Somme des valeurs / nombre de valeurs	Variables numériques sans valeur extrême
Médiane	Valeur du milieu quand les valeurs sont rangées	Variables avec des valeurs extrêmes
Étendue	Valeur maximale − valeur minimale	Dispersion simple
Écart-type	Mesure la dispersion autour de la moyenne	Dire si les valeurs sont proches ou éloignées de la moyenne

Calcul posé – Exemple : scores de connaissances sur 10, 10 participants, après l'atelier (fictif)

Valeurs rangées : 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9.

Moyenne = 68 / 10 = 6,8. Médiane = (7 + 7) / 2 = 7. Étendue = 9 − 4 = 5.

Écart-type (formule de l'échantillon, avec n − 1) = 1,75 (calculé avec un tableur, fonction ECARTYPE ou STDEV).

9.6.3 L'intervalle de confiance d'un pourcentage

Un pourcentage calculé sur un échantillon n'est qu'une estimation. L'intervalle de confiance à 95 % se calcule (quand n × p et n × (1 − p) dépassent 5) par : p ± 1,96 × racine carrée de [p × (1 − p) / n].

Calcul posé – Exemple

18 personnes sur 42 déclarent ne jamais cuisiner de légumes secs : p = 18 / 42 = 0,429.

Racine carrée de (0,429 × 0,571 / 42) = racine carrée de 0,00583 = 0,0764.

1,96 × 0,0764 = 0,150. Intervalle de confiance à 95 % : de 27,9 % à 57,8 %.

Interprétation : la vraie proportion dans la population se situe probablement entre 28 % et 58 %. Avec 42 personnes, l'estimation est très imprécise.

9.6.4 Choisir le bon graphique

Ce que l'on montre	Graphique adapté	À éviter
Répartition d'une variable en quelques catégories	Diagramme en barres (ou circulaire si 2 à 5 parts, total 100 %)	Camembert en 3D
Comparaison avant / après ou entre groupes	Barres groupées	Lignes entre catégories sans ordre
Évolution dans le temps	Courbe	Barres trop nombreuses
Distribution d'une variable numérique	Histogramme, boîte à moustaches	Moyenne seule
Réponses à choix multiples	Barres horizontales triées, en précisant « plusieurs réponses possibles »	Camembert (le total dépasse 100 %)

À retenir – Tout graphique a

un titre précis, l'effectif (n = …), les unités, la source (« enquête réalisée au centre social des Tilleuls, mars 2027, n = 42 ») et des axes lisibles.

9.7 Lire et écrire un article : la structure IMRAD

Partie	Contenu	Questions de lecture critique
Introduction	Contexte, question de recherche	La question est-elle claire ?
Méthodes (Material and methods)	Population, recrutement, outils, analyses	L'échantillon est-il adapté ? Y a-t-il un groupe témoin ?
Résultats	Chiffres, tableaux, figures	Les résultats répondent-ils à la question ? Les effectifs sont-ils donnés ?
Discussion	Interprétation, comparaison avec d'autres études, limites	Les auteurs reconnaissent-ils leurs limites ? Les conclusions vont-elles au-delà des résultats ?

Vérifiez aussi : qui a financé l'étude (conflits d'intérêts), dans quelle revue elle est publiée (comité de lecture) et sa date.

Partie 10 – Veille et recherche documentaire (C3.4)

10.1 Qu'est-ce que la veille ?

Définition – Veille

Activité organisée qui consiste à surveiller régulièrement des sources choisies pour repérer les informations nouvelles utiles à son métier : scientifiques (études, recommandations), professionnelles (outils, pratiques), réglementaires (lois, arrêtés, plans).

Type de veille	Exemples de sources	Fréquence conseillée en stage
Scientifique	PubMed, Cairn, Google Scholar, revues de nutrition, avis de l'Anses et du HCSP	Une fois par semaine
Professionnelle	Santé publique France (outils et campagnes), IREPS, Fnes, AFDN (Association française des diététiciens nutritionnistes), sites d'ARS	Une fois par semaine
Réglementaire	Légifrance, Journal officiel, sites des ministères de la Santé et de l'Agriculture	Une fois par semaine, et avant de rendre le dossier
Locale	Site de la commune, de la structure, presse locale	Pendant la période 1

10.2 Organiser sa veille

Méthode – Mettre en place une veille en 30 minutes

1. Listez 5 à 8 sources fiables (tableau ci-dessus).
2. Créez des alertes : alertes par courriel de Google Scholar ou de PubMed sur 2 ou 3 mots-clés (« cooking intervention », « food insecurity », « atelier culinaire »), lettres d'information de Santé publique France et de l'IREPS de votre région.
3. Prévoyez un créneau fixe chaque semaine (par exemple le vendredi, 30 minutes).
4. Remplissez une fiche de veille par document retenu.
5. Classez les fiches dans un dossier numérique nommé et daté.

Modèle à recopier – Fiche de veille

Rubrique	Contenu
Référence complète	Auteur, titre, source, date de publication, lien
Date de consultation	jj/mm/aaaa
Type	Scientifique, professionnelle, réglementaire
Fiabilité	Auteur identifié, organisme, date, références, conflits d'intérêts
Résumé en 3 lignes	
Intérêt pour mon projet	Ce que je change ou ce que je cite

10.3 Chercher efficacement

Technique	Exemple
Mots-clés en français et en anglais	« atelier culinaire » / « cooking class », « précarité alimentaire » / « food insecurity »

Technique	Exemple
Opérateurs booléens	ET (AND) : les deux termes ; OU (OR) : l'un ou l'autre ; SAUF (NOT) : exclure
Guillemets	« petit-déjeuner » cherche l'expression exacte
Filtres	Date (5 dernières années), langue, type de document
Recherche sur un site	site:santepubliquefrance.fr nutrition

10.4 Évaluer la fiabilité d'une source

Critère	Questions
Auteur	Qui écrit ? Est-il compétent ? Est-il identifiable ?
Organisme	Institution publique, société savante, revue à comité de lecture, entreprise, blog ?
Date	Le document est-il récent ? A-t-il été remplacé (exemple : PNNS 4 remplacé par le PNNS 5) ?
Objectif	Informer, vendre, convaincre ?
Références	Les affirmations sont-elles appuyées sur des études citées ?
Indépendance	Qui finance ? Y a-t-il un conflit d'intérêts ?
Cohérence	Les informations concordent-elles avec d'autres sources fiables ?

Erreurs fréquentes – Erreur fréquente

Citer un site commercial, un blog ou une vidéo comme source scientifique, ou reprendre une référence donnée par une IA sans l'avoir trouvée et lue soi-même.

10.5 Citer ses sources

Choisissez une norme et appliquez-la partout. Les deux plus courantes en santé sont la norme auteur-date (type APA) et la norme numérique (Vancouver). La norme française ISO 690 est aussi acceptée.

Exemple – Exemples en style auteur-date (à adapter à la norme demandée par votre établissement)

Rapport : Santé publique France. (2017). Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition (Esteban) 2014-2016. Volet nutrition. Chapitre corpulence. Saint-Maurice : Santé publique France.

Texte officiel : Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Journal officiel du 1er novembre 2018.

Site internet : Organisme. (année). Titre de la page. Consulté le jj/mm/aaaa, à l'adresse URL.

Partie 11 – Le dossier écrit E5 (le « mémoire »), le Word, le PDF, le diaporama et l'oral

Dans les classes, on appelle souvent ce document « le mémoire ». Le référentiel parle de **dossier écrit**. C'est lui qui sert de base à la soutenance du temps 1 de l'épreuve E5. Cette partie dit ce que les textes officiels imposent, ce qu'ils ne disent pas, et comment produire pas à pas le fichier Word, le PDF et le diaporama.

11.1 Ce que disent les textes officiels, et ce qu'ils ne disent pas

Règle	Ce que dit le texte	Source
Longueur	« La soutenance orale s'appuie sur un dossier écrit qui comporte 10 pages maximum, hors annexes »	Référentiel, définition de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024)
Contenu	À partir d'une situation vécue en milieu professionnel, le candidat conçoit et réalise tout ou partie d'un projet d'intervention en santé publique	Référentiel, E5
Compétences évaluées sur le dossier et l'oral	C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 (C3.2 est évaluée à part, dans l'atelier culinaire de 3 heures)	Référentiel, E5
Durée de l'oral	30 minutes : exposé de 10 minutes maximum, puis entretien de 20 minutes	Référentiel, E5
Jury	Des professeurs et des diététiciens	Référentiel, E5
Dépôt	Le dossier est déposé selon les modalités fixées par les autorités académiques (date, format, nombre d'exemplaires, plateforme)	Référentiel, E5
Sanction	Pas de dépôt, ou dépôt après la date fixée par la circulaire : l'épreuve n'est pas validée. Le candidat ne peut pas être interrogé, même s'il est présent, et le diplôme ne peut pas lui être délivré	Référentiel, E5
Attestations de stage	Sans les attestations des stages de restauration collective et d'interventions en santé publique, le candidat n'est pas autorisé à passer l'E5	Référentiel, annexe sur les stages
Contrôle en cours de formation (CCF)	Deux situations au cours de la 2e année : la première évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 à partir du projet ; la seconde évalue C3.2. Le niveau d'exigence est le même qu'à l'épreuve ponctuelle	Référentiel, E5
Redoublement	Le candidat peut présenter son dossier précédent, éventuellement modifié, ou un nouveau dossier après de nouveaux stages	Référentiel, annexe sur les stages
Qualités attendues du projet	Le projet doit être « transférable, efficace, reproductible et adaptable sur le terrain »	Guide d'accompagnement du 29 avril 2025, p. 59

Attention – Ce que les textes ne fixent pas

Le référentiel et le guide d'accompagnement ne fixent **ni la police, ni la taille des caractères, ni l'interligne, ni les marges**. Ils ne disent pas non plus si la page de garde, le sommaire et la bibliographie comptent dans les 10 pages. Toutes les règles de mise en forme données dans cette partie sont des **recommandations**. La règle qui s'impose est celle de la **circulaire d'organisation de l'examen de votre académie** et des consignes de votre établissement. Demandez-la à votre enseignant dès le début de la 2e année, et relisez-la avant le dépôt.

Méthode – Les questions à poser à l'établissement dès la rentrée de 2e année

- Quelle est la date limite de dépôt, et comment dépose-t-on le dossier (plateforme, courriel, papier) ? Combien d'exemplaires faut-il ?
- La page de garde, le sommaire et la bibliographie comptent-ils dans les 10 pages ?
- Y a-t-il une limite au nombre de pages d'annexes ou à la taille du fichier ?
- Faut-il un format de fichier ou un nom de fichier précis ?
- Le jour de l'oral, un vidéoprojecteur est-il prévu ? Peut-on apporter un diaporama, un ordinateur ou des documents papier ?
- Si vous êtes en CCF : à quelle date a lieu la première situation d'évaluation ?

11.2 Chaque jour de stage nourrit une partie du dossier

Le dossier se prépare pendant le stage, pas après. Le Guide du stage jour par jour contient, pour chaque journée, un encadré **« Pour le dossier E5 »**. Il indique la partie du dossier que la journée alimente, la preuve à garder et la photo ou le document à rapporter. Le tableau ci-dessous en donne la vue d'ensemble.

Partie du dossier (plan conseillé en 11.3)	Journées du guide qui la nourrissent	Preuves à avoir en fin de stage
1. Introduction	P1 J1, J2 ; P2 J1	Fiche identité de la structure, mission confiée, accord de la structure pour être citée
2. Contexte et diagnostic	P1 J2 à J11, J14	Portrait du territoire sourcé et daté, tableau des politiques, questionnaire, synthèse des entretiens, compte rendu du groupe de parole, résultats chiffrés, tableau de croisement, arbre à problèmes
3. Priorités et objectifs	P1 J12, J15	Grille de priorisation validée, arbre des objectifs, objectifs SMART avec indicateurs
4. Conception du projet	P1 J13, J15 ; entre les deux périodes ; P2 J1 à J4	Fiche projet, plan d'action, budget, Gantt, plan de communication, conducteurs, fiches techniques, mention RGPD, modèles d'autorisation
5. Mise en œuvre	P2 J3 à J13	Émargements chiffrés (sans nom), comptes rendus, écarts au conducteur, ajustements validés, grille d'observation de votre animation, photos autorisées
6. Évaluation	P2 J6, J10, J12, J15 à J17	Tableau de bord, questionnaires vierges avant et après, résultats calculés deux fois, limites
7. Valorisation, auto-évaluation et ajustements	P1 J15 ; P2 J13, J14, J18 à J20	Support de valorisation, compte rendu de restitution, outils transmis, auto-évaluations, avis du tuteur
Bibliographie et veille	P1 J3, J4, J13 ; P2 J14	Tableau des références, fiches de veille, dates de consultation

À retenir – Le réflexe du soir

Chaque soir, en remplissant le journal de bord, demandez-vous : « Dans quelle partie du dossier cette journée ira-t-elle ? Quelle preuve ai-je gardée ? » Une preuve non gardée le jour même est presque toujours perdue.

11.3 Le plan conseillé et le budget de pages

Le plan suit la démarche de projet et les indicateurs d'évaluation de la compétence C3.1 du référentiel. Le nombre de pages est un **maximum conseillé**. Visez un total de 9 à 9,5 pages pour garder une marge.

Partie	Pages (maximum conseillé)	Ce qu'on y trouve	Indicateurs du référentiel démontrés
Page de garde et sommaire	Hors budget (à vérifier dans la circulaire)	Titre du projet, nom, session, structure (avec son accord), sommaire automatique	–
1. Introduction	0,5	Structure, public, mission confiée, problématique en une phrase, annonce du plan	C3.1 : contexte
2. Contexte et diagnostic	2	Territoire et politiques (sources datées) ; méthode de recueil (outils, période, nombre de personnes) ; résultats clés ; besoins classés (Bradshaw) ; ressources ; arbre à problèmes	C3.1 : analyse et diagnostic de situation posé ; C3.3 : contexte et problématique, méthodes et outils de collecte ; C3.4 : sources fiables
3. Priorités et objectifs	1	Problème retenu et pourquoi (grille) ; objectif général, objectifs spécifiques et opérationnels SMART, chacun avec son indicateur	C3.1 : priorités et objectifs formulés et adaptés au contexte
4. Conception du projet	1,5	Plan d'action, partenaires, moyens, budget, calendrier ; plan de communication ; démarche d'évaluation prévue ; éthique, RGPD et sécurité des données	C3.1 : plan d'action réaliste, plan de communication, démarche d'évaluation construite, règles éthiques ; C3.5 : précarité numérique, supports adaptés ; C3.6 : environnement numérique sécurisé
5. Mise en œuvre	1,5	Ce qui a été réalisé, quand, avec qui, combien de participants ; écarts au prévu et ajustements ; votre posture d'animateur	C3.1 : projet mis en œuvre ; C3.5 : techniques d'animation, écoute active, posture professionnelle
6. Évaluation	2	Présentée comme un petit rapport d'étude : objectif, méthode (population, outil, période, n), résultats (tableau de bord), discussion et limites	C3.1 : évaluation ; C3.3 : traitement et analyse des données, normes du rapport d'étude
7. Valorisation, auto-évaluation et ajustements	1	Supports produits, restitution, suite du projet ; auto-évaluation argumentée par compétence ; ajustements envisagés	C3.1 : valorisation, auto-évaluation argumentée, ajustements envisagés ; C3.4 : diffusion de la veille ; C3.5 : auto-évaluation de l'intervention
8. Conclusion	0,5	Réponse à la problématique, apports pour le public, la structure et vous, ouverture	–
Bibliographie	Une page à part (à vérifier dans la circulaire)	Toutes les sources citées, une seule norme	C3.3 : recherche bibliographique et codification ; C3.4

Partie	Pages (maximum conseillé)	Ce qu'on y trouve	Indicateurs du référentiel démontrés
Annexes	Hors des 10 pages	Sommaire des annexes, puis les annexes numérotées	Preuves

Astuce de stagiaire – Où montrer C3.4 et C3.6, souvent oubliées

- **C3.4 (veille)** : un paragraphe de 5 à 6 lignes dans la partie 2 ou 7 décrit votre démarche (sources surveillées, alertes, fréquence, ce que la veille a changé dans le projet), avec deux fiches de veille en annexe.
- **C3.6 (numérique sécurisé)** : un paragraphe dans la partie 4 décrit le stockage (espace sécurisé de la structure, mot de passe, double authentification), les sauvegardes (règle 3-2-1), le codage des participants, la suppression des données à une date fixée, et la conduite tenue face à un incident (courriel suspect, clé perdue) si cela s'est produit.

11.4 Les règles de rédaction

Méthode – Écrire clair

- Des phrases courtes : une idée par phrase, 20 mots environ.
- Le « je » pour ce que vous avez fait seul, le « nous » pour ce qui a été fait avec l'équipe. Restez constant.
- Le passé composé pour raconter ce qui a été fait, le présent pour analyser.
- Un titre numéroté qui annonce le contenu de chaque partie (« 2.3 Les familles cuisinent peu les légumes secs »).
- Une phrase de transition à la fin de chaque partie.
- Le vocabulaire du métier, défini à la première utilisation (besoin ressenti, objectif opérationnel, indicateur de processus).
- Pas de jugement sur le public (« les gens ne savent pas manger ») : on décrit des faits et des freins.

Méthode – Chiffres, tableaux et figures

- Chaque chiffre a sa source et l'année des données entre parenthèses : « 45 % des répondants ne mangent jamais de légumes secs (questionnaire, n = 40, mai 2027) ».
- Sur un petit effectif (moins de 20), écrivez « 9 sur 10 » plutôt qu'un pourcentage.
- Chaque calcul est refait deux fois avant d'être écrit.
- Les tableaux et les figures sont numérotés, titrés et cités dans le texte (« voir tableau 2 »). Le titre d'un tableau se place au-dessus, celui d'une figure en dessous ; la source se place sous le tableau ou la figure.
- Un tableau ou une figure ne remplace pas le texte : écrivez une ou deux phrases qui disent ce qu'il montre.
- Les données fictives (exemples, simulations) sont signalées comme telles.

Méthode – Sources et bibliographie

- Une seule norme dans tout le dossier : auteur-date (type APA) ou numérique (Vancouver). Suivez celle que demande l'établissement (cours 10.5).
- Dans le texte, chaque source est appelée : (Santé publique France, 2017) en auteur-date, ou [3] en numérique.
- Pour une page internet, notez la date de consultation.
- Citez les plans en vigueur : PNNS 5 (2026-2030), SNANC 2025-2030, PNA 4. Ne présentez jamais le PNNS 4 comme le plan actuel.

- Ne citez aucune référence que vous n'avez pas lue vous-même, en particulier une référence proposée par une IA.

Méthode – Éthique, anonymat et intelligence artificielle

- Aucun nom de participant, aucune adresse, aucune date de naissance, aucune donnée de santé individuelle : codes (P01, P02…) ou prénoms fictifs signalés comme tels.
- Les professionnels sont désignés par leur fonction (« l'animatrice famille »).
- Le nom de la structure, son logo et ses documents internes ne sont cités qu'avec l'accord écrit de sa direction (modèle en 11.8). Sinon, écrivez par exemple « un centre social d'une ville de 40 000 habitants ».
- Si vous avez utilisé une IA (reformulation, correction, idées), dites-le en une phrase dans la partie méthode ou en note : outil, usage, vérification faite. L'analyse reste la vôtre.

Erreurs fréquentes – Les erreurs qui coûtent le plus de points

Dépasser 10 pages hors annexes, rendre hors délai, réduire le diagnostic à une liste de chiffres, écrire des objectifs non mesurables, évaluer seulement la satisfaction, oublier les limites, citer des plans périmés, publier un nom ou une photo sans autorisation, mettre en annexe des documents que le texte ne cite jamais.

11.5 Les annexes

Les annexes sont des **preuves**. Elles ne comptent pas dans les 10 pages, mais le jury les lit pour vérifier ce que vous affirmez. Chaque annexe doit être citée au moins une fois dans le texte.

Annexes conseillées	Remarque
Fiche identité de la structure	Sans nom de bénéficiaire
Portrait du territoire et tableau des politiques	Sources et dates
Questionnaire vierge et guide d'entretien vierge	Jamais les questionnaires remplis
Résultats détaillés et graphiques	Avec n et source
Arbre à problèmes et arbre des objectifs	–
Fiche projet, plan d'action, Gantt, budget	Prévu et réalisé
Plan de communication et supports (affiche, flyer, livret)	Version finale validée
Conducteurs de séance et fiches techniques	Avec coût par portion et allergènes
Tableau de bord	Cibles, résultats, écarts
Comptes rendus (restitution, comité de pilotage)	Personnes désignées par leur fonction
Deux fiches de veille	Datées
Photos autorisées	Légendées et datées
Auto-évaluation par compétence et grille d'observation de votre animation	–

Astuce de stagiaire – Organiser les annexes

Commencez par un sommaire des annexes (numéro, titre, page). Numérotez les annexes dans l'ordre où le texte les cite. Si le volume d'annexes n'est pas limité par la circulaire, gardez seulement les preuves utiles : 15 à 25 pages suffisent en général. C'est une recommandation, pas une règle officielle.

11.6 Faire le fichier Word pas à pas

Les menus ci-dessous sont ceux de Microsoft Word (version Microsoft 365). Sous LibreOffice Writer, les fonctions existent aussi : l'équivalent est indiqué entre crochets.

Méthode – 1. Préparer le document avant d'écrire

1. Créez un nouveau document et enregistrez-le tout de suite avec un nom daté : NOM_Prenom_E5_dossier_v01_2027-01-15.docx.
2. Réglez la langue : Révision > Langue > Définir la langue de vérification > Français.
3. Réglez les marges : Mise en page > Marges > Marges personnalisées. Recommandation : 2,5 cm partout. [LibreOffice : Format > Page]
4. Réglez le style « Normal » : Accueil, clic droit sur le style Normal > Modifier. Recommandation : police lisible (Arial, Calibri ou Liberation Sans) en 11 ou 12 points, interligne 1,15, 6 points d'espace après chaque paragraphe, texte justifié ou aligné à gauche. [LibreOffice : touche F11, style « Corps de texte »]
5. Réglez les styles « Titre 1 » (parties) et « Titre 2 » (sous-parties) de la même façon : taille plus grande, gras, couleur sobre.
6. Numérotez les titres automatiquement : Accueil > Liste à plusieurs niveaux > choisissez le modèle « 1 Titre 1, 1.1 Titre 2 ». [LibreOffice : Outils > Numérotation des chapitres]

Méthode – 2. Écrire avec les styles

1. Tapez chaque titre, puis cliquez sur le style « Titre 1 » ou « Titre 2 ». Ne mettez jamais un titre en forme « à la main » (gras et taille) : le sommaire ne le verrait pas.
2. Pour changer de page, utilisez Ctrl + Entrée (saut de page), jamais une série de lignes vides.
3. Affichez le volet de navigation (Affichage > Volet de navigation) pour voir le plan et vous déplacer.
4. Pour un tableau : Insertion > Tableau. Sur la ligne de titre : Disposition > Répéter les lignes d'en-tête.
5. Pour une image : Insertion > Images, puis Format de l'image > Habillage > « Aligné sur le texte », pour qu'elle ne bouge pas.

Méthode – 3. Légendes, renvois et sommaire automatiques

1. Légende : clic droit sur le tableau ou la figure > Insérer une légende > « Tableau » ou « Figure ». Word numérote seul. [LibreOffice : Insertion > Légende]
2. Renvoi dans le texte : Références > Renvoi > choisissez la légende. Si vous ajoutez un tableau, les numéros se mettent à jour. [LibreOffice : Insertion > Champ > Renvoi]
3. Sommaire : placez le curseur après la page de garde, puis Références > Table des matières > Table automatique. [LibreOffice : Insertion > Table des matières et index]
4. Avant chaque export, mettez à jour : clic droit sur le sommaire > Mettre à jour les champs > Mettre à jour toute la table. Faites de même avec Ctrl + A puis F9 pour tous les renvois.

Méthode – 4. Numéros de page, page de garde et annexes

1. Insertion > Numéro de page > Bas de page.
2. Pour ne pas numéroter la page de garde : double-cliquez dans le pied de page > cochez « Première page différente ».
3. Pour séparer les annexes : Mise en page > Sauts de page > Section : page suivante. Dans la nouvelle section, désactivez « Lier au précédent » dans le pied de page et faites recommencer la numérotation (Format des numéros de page > À partir de 1), ou utilisez « A1, A2… ».
4. Vérifiez le nombre de pages du corps du dossier dans la barre d'état en bas de l'écran.

Méthode – 5. Relire et nettoyer

1. Révision > Grammaire et orthographe : corrigez tout.
2. Si des personnes ont relu avec le suivi des modifications : Révision > Accepter > Accepter toutes les modifications, puis supprimez tous les commentaires.
3. Fichier > Informations > Vérifier l'absence de problèmes > Inspecter le document : supprimez les propriétés et informations personnelles cachées.
4. Faites relire le dossier par une autre personne, puis relisez une dernière fois chaque chiffre avec sa source.

À retenir – Versions et sauvegardes (C3.6)

Changez le numéro de version à chaque grande étape (v01, v02…), sans écraser l'ancienne. Appliquez la règle 3-2-1 : 3 copies, sur 2 supports différents, dont 1 hors de chez vous (espace en ligne de l'établissement). Une perte de fichier la veille du dépôt n'est pas une excuse recevable.

11.7 Faire le PDF

Le PDF fige la mise en page : le jury voit exactement ce que vous voyez, sur n'importe quel ordinateur.

Méthode – Exporter en PDF

1. Mettez à jour le sommaire et les renvois (11.6, étape 3).
2. Word : Fichier > Enregistrer sous > choisissez le type « PDF ». Cliquez sur Options et cochez « Créer des signets à l'aide des titres » et « Conforme à la norme ISO 19005-1 (PDF/A) », qui intègre les polices. Choisissez « Standard (publication en ligne et impression) ».
3. LibreOffice : Fichier > Exporter au format PDF. Cochez « Archive PDF/A » et « Exporter les plans » (les signets). Gardez une qualité d'image de 90 % et une résolution de 300 ppp.
4. Nommez le fichier selon la consigne de l'académie. À défaut : NOM_Prenom_E5_dossier_2027.pdf, sans accent ni espace.

Check-list – Vérifier le PDF avant de le déposer

- ☐ Le PDF s'ouvre sur un autre ordinateur ou sur un téléphone
- ☐ Le corps du dossier fait 10 pages au maximum (vérifiez la règle de la circulaire pour la page de garde, le sommaire et la bibliographie)
- ☐ Les numéros de page du sommaire sont justes
- ☐ Les signets apparaissent dans le panneau latéral
- ☐ Les images et graphiques sont nets, les tableaux ne sont pas coupés
- ☐ Aucun commentaire ni marque de révision n'apparaît
- ☐ Aucun nom de participant, aucune photo sans autorisation
- ☐ La taille du fichier respecte la limite de la plateforme de dépôt, s'il y en a une
- ☐ Le fichier porte le bon nom
- ☐ Le dossier est déposé avant la date limite, et la preuve du dépôt (accusé de réception, capture d'écran datée) est conservée

Astuce de stagiaire – Si le fichier est trop lourd

Dans Word, sélectionnez une image > Format de l'image > Compresser les images > décochez « Appliquer à cette image uniquement » > choisissez 150 ppp. Exportez de nouveau. Les photos prises au téléphone sont souvent très lourdes : réduisez-les avant de les insérer.

11.8 Les photos et documents à rapporter de la structure

Des photos et des documents bien choisis rendent le dossier et l'oral concrets. Ils doivent tous respecter trois règles : **autorisation, anonymat, utilité**.

11.8.1 La liste de ce qu'il faut rapporter

À rapporter	À quoi cela sert (partie du dossier)	Règle à respecter
Photos des locaux sans personne : cuisine, salle d'activité, affichage	Introduction, conception (moyens matériels)	Accord du responsable de la structure ; pas de document lisible ni de nom affiché
Photos de l'offre alimentaire du quartier (marché, épicerie solidaire, rayons)	Diagnostic	Pas de personne reconnaissable ; accord du commerçant si vous photographiez dans un magasin
Photos des feuilles du groupe de parole, du photolangage, du tableau de synthèse	Diagnostic	Aucun prénom écrit dessus
Photo de l'affiche posée à l'accueil et des supports diffusés	Conception, mise en œuvre (plan de communication)	Version validée par le tuteur
Photos des plats réalisés à chaque atelier	Mise en œuvre, diaporama	Libre si aucune personne n'apparaît
Photos des mains en action, des postes de travail, de la dégustation de dos	Mise en œuvre, diaporama	Personne reconnaissable : autorisation écrite obligatoire (11.8.2) ; sinon cadrez ou floutez
Photo de groupe avec des visages	Seulement si indispensable	Autorisation écrite de chaque adulte ; pour un mineur, autorisation des deux parents et avis de l'enfant
Captures du tableur, des graphiques, du tableau de bord	Diagnostic, évaluation	Données anonymes uniquement
Livret de recettes, flyer, jeu ou outil créé	Valorisation, annexes	Mention des sources des images utilisées
Questionnaire vierge, guide d'entretien vierge, grilles d'évaluation vierges	Annexes	Jamais les exemplaires remplis
Fiches techniques, conducteurs, budget avec tickets récapitulés	Conception, mise en œuvre	Pas de numéro de carte bancaire ni de nom sur les tickets
Comptes rendus de réunion et de restitution	Mise en œuvre, valorisation	Personnes désignées par leur fonction
Extraits du projet de structure ou du rapport d'activité (chiffres)	Introduction, diagnostic	Accord écrit de la direction pour citer un document interne
Grille d'observation de votre animation remplie par le tuteur, son évaluation	Auto-évaluation	Avec son accord
Courriel ou fiche de validation des documents par le tuteur	Conception, preuve de la démarche	Adresse et nom masqués si nécessaire
Attestation de stage signée (une par période si votre établissement le demande)	Dossier administratif, condition pour passer l'E5	Original remis à l'établissement, copie gardée

Point de vigilance – Ce qui ne sort jamais de la structure

Questionnaires remplis, fiches d'inscription, liste des codes et des prénoms, listes d'émargement nominatives (gardez seulement le nombre de présents), coordonnées des participants, toute donnée de santé individuelle, documents marqués « confidentiel », photos d'enfants sans double autorisation parentale.

11.8.2 Le droit à l'image et les données personnelles

- Toute personne a droit au respect de sa vie privée, y compris de son image (article 9 du Code civil). Photographier une personne reconnaissable et utiliser la photo demande son **autorisation écrite**, qui précise le support, l'usage, la durée et le droit de retirer son accord.
- Fixer ou transmettre sans son consentement l'image d'une personne qui se trouve dans un lieu privé est un délit (article 226-1 du Code pénal).
- Pour un **mineur**, la loi du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants (loi n° 2024-120) précise que les parents protègent **ensemble** le droit à l'image de leur enfant et l'associent selon son âge et sa maturité (article 372-1 du Code civil). Demandez donc la signature des deux parents et l'accord de l'enfant.
- Une photo où une personne est reconnaissable est une **donnée personnelle** au sens du RGPD (règlement 2016/679) : finalité écrite, conservation limitée, stockage sécurisé.
- Le flou doit rendre la personne vraiment méconnaissable (visage, tatouage, vêtement très particulier, voix sur une vidéo).
- Désactivez la géolocalisation de l'appareil photo, ou supprimez les données de localisation de la photo avant de l'utiliser. Utilisez de préférence l'appareil de la structure.

Modèle à recopier – Autorisation de droit à l'image (adulte)

Je soussigné(e) [prénom, nom], autorise [prénom, nom de l'étudiant(e)], étudiant(e) en BTS Diététique et nutrition, en stage au [structure], à me photographier lors de l'atelier du [date] et à utiliser ces photos uniquement dans son dossier d'examen (BTS, épreuve E5) et lors de sa soutenance orale, sans diffusion sur internet ni sur les réseaux sociaux.

Mon nom ne sera jamais associé à la photo. Cette autorisation est valable jusqu'au [date de fin de la session d'examen]. Je peux la retirer à tout moment en le disant à [contact de la structure] : les photos seront alors supprimées.

Fait à ....., le ..... Signature :

Modèle à recopier – Autorisation de droit à l'image (mineur)

Nous soussignés [prénom, nom du parent 1] et [prénom, nom du parent 2], titulaires de l'autorité parentale de [prénom de l'enfant], autorisons [prénom, nom de l'étudiant(e)], étudiant(e) en BTS Diététique et nutrition, en stage au [structure], à photographier notre enfant lors de l'atelier du [date] et à utiliser ces photos uniquement dans son dossier d'examen (BTS, épreuve E5) et lors de sa soutenance orale, sans diffusion sur internet ni sur les réseaux sociaux. Le nom de notre enfant ne sera jamais associé à la photo. Notre enfant a été informé et est d'accord : oui / non. Cette autorisation est valable jusqu'au [date] et peut être retirée à tout moment auprès de [contact de la structure].

Fait à ....., le ..... Signatures des deux parents :

Modèle à recopier – Accord de la structure pour citer son nom et ses documents

Je soussigné(e) [prénom, nom], [fonction] de [structure], autorise [prénom, nom de l'étudiant(e)] à citer le nom de la structure [et à reproduire son logo : oui / non] et à utiliser les documents suivants : [liste : rapport d'activité 2026 (chiffres), projet social (extrait), photos des locaux], uniquement dans son dossier d'examen BTS (épreuve E5) et lors de la soutenance orale.

Je demande que : [la structure soit anonymisée / aucune autre restriction].

Fait à ....., le ..... Signature et cachet :

Astuce de stagiaire – Une légende complète pour chaque photo

« Figure 4 – Préparation du dahl de lentilles corail, atelier 2 du 18 mai 2027 (photo de l'auteur, mains de participants, autorisation écrite recueillie). » La légende dit quoi, quand, qui a pris la photo, et que l'autorisation existe.

11.9 Le diaporama de soutenance (PowerPoint)

Le référentiel ne dit pas si un diaporama est obligatoire ou permis : vérifiez dans la circulaire et la convocation quel matériel est prévu (vidéoprojecteur, ordinateur) et ce que vous pouvez apporter. Préparez dans tous les cas une version PDF et une version papier.

Diapositive	Contenu	Minutes de l'exposé (11.10)
1	Titre du projet, votre nom, session, structure (avec son accord)	0 à 0,5
2	La structure et le public en 3 éléments, la problématique en une phrase	0,5 à 1
3	Méthode du diagnostic : sources, outils, nombre de personnes	1 à 2
4	3 chiffres clés du diagnostic (un graphique simple)	2 à 3
5	Le problème prioritaire et les objectifs (général, spécifiques)	3 à 4
6	Le plan d'action : actions, partenaires, calendrier, budget	4 à 5
7	Une action en images : photo autorisée du plat ou des mains, une phrase	5 à 6
8	L'évaluation : tableau de bord simplifié	6 à 7,5
9	Les limites et les ajustements	7,5 à 8
10	Auto-évaluation : 2 compétences développées, 1 axe de progrès	8 à 9
11	Conclusion : apports pour le public, la structure, vous ; suite du projet	9 à 10
Réserve	Après la conclusion : questionnaire, arbre à problèmes, budget détaillé, Gantt. Vous ne les montrez que si le jury pose une question	–

Méthode – Fabriquer le diaporama

1. Format 16:9 (Conception > Taille des diapositives).
2. Réglez les polices et les couleurs une seule fois dans le masque : Affichage > Masque des diapositives. Deux couleurs sobres et une couleur d'accent, fond clair et texte foncé.
3. Taille du texte : 24 points au minimum, titres de 32 à 40 points ; 6 lignes au maximum par diapositive ; une idée par diapositive.
4. Graphiques simples : un seul message par graphique, n et source en bas de la diapositive (14 points).
5. Numérotez les diapositives (Insertion > Numéro de diapositive) : le jury pourra dire « revenez à la 8 ».
6. Pas d'animations décoratives ; une apparition progressive est utile seulement pour un tableau de bord.
7. Écrivez vos phrases clés dans les notes du présentateur (Affichage > Page de notes), pas sur la diapositive.
8. Intégrez les polices : Fichier > Options > Enregistrement > « Incorporer les polices dans le fichier ».
9. Exportez une copie en PDF : Fichier > Exporter > Créer un document PDF/XPS. [LibreOffice Impress : Fichier

> Exporter au format PDF]

10. Le jour J : le fichier .pptx et le PDF sur une clé USB et dans votre espace en ligne, plus une version papier (3 diapositives par page) pour vous et, si c'est autorisé, pour le jury.

Astuce de stagiaire – Répéter avec le minutage

Diaporama > Vérifier le minutage enregistre le temps passé sur chaque diapositive. Le mode Présentateur (Diaporama > Utiliser le mode Présentateur) affiche vos notes et un chronomètre. Répétez au moins trois fois, debout, devant quelqu'un.

11.10 L'exposé de 10 minutes maximum

Minutes	Contenu
0 à 1	Présentation, structure, public, problématique en une phrase
1 à 3	Diagnostic : 3 chiffres clés, besoins du public, priorité retenue
3 à 4	Objectifs (général et spécifiques)
4 à 6	Actions réalisées (un support visuel), partenaires, budget
6 à 8	Évaluation : tableau de bord, résultats, limites
8 à 9	Auto-évaluation et ajustements
9 à 10	Conclusion : ce que le projet a apporté au public, à la structure et à vous

Astuce de stagiaire – S'entraîner

Faites l'exposé trois fois devant quelqu'un, chronomètre en main. Visez 9 minutes 30 : le texte dit « 10 minutes maximum ». Si vous dépassez, coupez dans la description de la structure, jamais dans l'évaluation.

11.11 L'entretien de 20 minutes

Le jury part de votre dossier et vous questionne sur vos choix, vos méthodes et vos connaissances. L'annexe A du cours complet propose 30 questions fréquentes avec des pistes de réponse. Voici la méthode pour répondre à n'importe quelle question.

Méthode – Répondre en quatre temps

1. Reformuler brièvement la question si elle est complexe.
2. Répondre directement en une phrase.
3. Justifier avec un exemple tiré de votre stage ou une donnée sourcée.
4. Ouvrir : une limite, une amélioration, un lien avec une autre compétence.

Exemple : « Votre échantillon est-il représentatif ? » « Non. J'ai interrogé 42 personnes présentes au centre social les mardis et mercredis, donc les familles qui travaillent en journée sont sous-représentées. Pour une prochaine enquête, je déposerais aussi les questionnaires à l'épicerie solidaire le samedi. »

Questions probables du jury – Questions probables sur le dossier lui-même

- Pourquoi avez-vous retenu cette priorité plutôt qu'une autre ?
- Comment avez-vous protégé les données des participants ? Où sont-elles aujourd'hui ?
- Quelles sources avez-vous surveillées pendant le stage ? Qu'est-ce que votre veille a changé ?
- Votre projet est-il reproductible dans une autre structure ? Que faudrait-il adapter ?

- Avez-vous utilisé une intelligence artificielle ? Pour quoi faire, et comment avez-vous vérifié ?

11.12 L'auto-contrôle final avec les indicateurs du référentiel

Avant le dépôt, vérifiez que chaque indicateur d'évaluation du référentiel pour les compétences évaluées sur le dossier trouve sa place. Écrivez le numéro de la partie et de l'annexe qui le prouvent.

Compétence	Indicateur d'évaluation (référentiel 2024)	Partie du dossier	Annexe
C3.1	Analyse et diagnostic de situation posé		
C3.1	Priorités et objectifs formulés et adaptés au contexte		
C3.1	Plan d'action et moyens de mise en œuvre réalistes		
C3.1	Plan de communication et modalités de mise en œuvre adaptés		
C3.1	Démarche d'évaluation du projet construite		
C3.1	Projet mis en œuvre		
C3.1	Autoévaluation du projet argumentée		
C3.1	Ajustements envisagés		
C3.1	Valorisation du projet		
C3.1	Règles éthiques, juridiques et déontologiques respectées		
C3.3	Règles de déontologie et d'éthique prises en compte		
C3.3	Méthodologie de recherche bibliographique et codification maîtrisée		
C3.3	Contexte et problématique de l'étude identifiés et exposés		
C3.3	Méthodes et outils de collecte de données pertinents		
C3.3	Traitement et analyse des données, réalisés		
C3.3	Normes et critères de rédaction du rapport d'étude respectés		
C3.3	Connaissance des enjeux liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle		
C3.3	Principes éthiques associés au traitement des données numériques en santé maîtrisés		
C3.4	Besoins et objectifs (de la veille) identifiés		
C3.4	Technique de veille maîtrisée et adaptée au contexte		
C3.4	Sources d'informations fiables repérées et connues		
C3.4	Informations collectées, analysées et organisées		
C3.4	Informations à diffuser sélectionnées en fonction des besoins identifiés		
C3.4	Modalités de diffusion organisées et adaptées aux destinataires		
C3.4	Pertinence de la veille évaluée		
C3.5	Moyens de communication connus et maîtrisés		
C3.5	Précarité numérique repérée et prise en compte		
C3.5	Supports de communication et contenu adaptés au public		
C3.5	Outils numériques adaptés à la communication		
C3.5	Expression écrite et orale maîtrisée et adaptée		
C3.5	Capacités d'écoute active mobilisées		

Compétence	Indicateur d'évaluation (référentiel 2024)	Partie du dossier	Annexe
C3.5	Techniques d'animation et posture professionnelle adaptées au contexte		
C3.5	Auto-évaluation de l'intervention réalisée		
C3.5	Enjeux liés à la e-réputation pris en compte		
C3.5	Bonnes pratiques de connexion à des plateformes		
C3.5	Gestion de l'identité numérique maîtrisée		
C3.6	Référentiels de référence en cybersécurité identifiés		
C3.6	Environnement numérique de travail géré et sécurisé		
C3.6	Bonnes pratiques d'utilisation de messagerie et de courriels respectées		
C3.6	Différents types d'actions malveillantes connues		
C3.6	Prévention contre les virus et les actes malveillants mise en œuvre		
C3.6	Réaction face aux incidents appropriée		

Astuce de stagiaire – Tout ne tient pas dans 10 pages

Certains indicateurs de C3.5 et C3.6 (e-réputation, connexion aux plateformes, actions malveillantes) se montrent surtout à l'oral et dans les annexes. Préparez une phrase d'exemple pour chacun : le jury peut vous interroger dessus pendant l'entretien. Pour C3.6, citez les références de cybersécurité que vous connaissez, par exemple le guide d'hygiène informatique de l'ANSSI ou le site cybermalveillance.gouv.fr.

11.13 Le calendrier du dossier, du stage au dépôt

Moment (guide d'accompagnement, tableau 1)	Ce que vous faites pour le dossier
Période 1 (fin de 1re année)	Journal de bord chaque soir ; preuves rangées dans le dossier numérique ; accords de la structure demandés
Début de 2e année	Rédaction des parties 1 à 3 au propre pendant la conception du projet ; parties 4 rédigée au fur et à mesure
Période 2 (milieu de 2e année)	Preuves de mise en œuvre et d'évaluation ; autorisations de droit à l'image signées avant chaque photo ; attestation de stage
Fin de 2e année : retour réflexif	Rédaction des parties 5 à 8 en 6 semaines (Guide du stage, « Après le stage ») ; relecture ; Word puis PDF
Au plus tard quelques jours avant la date limite	Dépôt selon la circulaire ; preuve du dépôt conservée
Les semaines suivantes	Diaporama, répétitions de l'exposé et de l'entretien

Partie 12 – Boîte à outils : modèles et glossaire

12.1 Fiche identité de la structure

Rubrique	À compléter
Nom, statut juridique (association, collectivité, établissement public…)	
Missions, projet de structure	
Public accueilli : nombre, âges, profil	
Équipe : fonctions, nombre	
Locaux et matériel (cuisine, salle, équipement)	
Financements principaux	
Partenaires	
Actions en nutrition déjà menées	
Inscription dans un CLS, un PAT, un quartier prioritaire	
Tuteur : nom, fonction, disponibilités	

12.2 Grille d'observation

Date, lieu, moment	Ce que j'observe (faits)	Nombre ou fréquence	Mon interprétation (à vérifier)

12.3 Guide d'entretien avec un professionnel

1. Pouvez-vous me présenter votre rôle dans la structure ?
2. Quel public rencontrez-vous ? Quelles difficultés liées à l'alimentation observez-vous ?
3. Qu'est-ce qui a déjà été fait sur ce sujet ? Qu'est-ce qui a marché ou non ?
4. Selon vous, de quoi le public aurait-il besoin ?
5. Quelles ressources (lieux, matériel, partenaires, budget) seraient disponibles ?
6. Comment pourriez-vous participer au projet ?
7. Y a-t-il des points de vigilance (sujets sensibles, règles de la structure) ?

12.4 Journal de bord : la page du jour

Modèle à recopier – Page quotidienne du journal de bord

Rubrique	À remplir chaque soir (10 minutes)
Date, horaires, jour n°	
Ce que j'ai fait (faits, chiffres)	
Personnes rencontrées (fonction, sans nom de bénéficiaire)	
Informations recueillies (avec la source)	
Décisions prises, validations du tuteur	
Difficultés et comment je les ai gérées	
Compétence travaillée (C3.1 à C3.6) et preuve conservée	
Pour le dossier E5 : partie nourrie, photo ou document rapporté	

Rubrique	À remplir chaque soir (10 minutes)
Ce que j'ai appris	
À faire demain	

12.5 Glossaire

Terme	Définition courte
ARS	Agence régionale de santé, pilote la santé dans la région
Arbre à problèmes	Schéma qui relie un problème central à ses causes et à ses effets
Besoin (Bradshaw)	Normatif, ressenti, exprimé ou comparatif
Biais	Erreur systématique qui fausse un résultat
CLS	Contrat local de santé, entre l'ARS et une collectivité
Conducteur de séance	Déroulé minuté d'une séance
CPS	Compétences psychosociales
DADFMS	Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales
Déterminant de santé	Facteur qui influence la santé
Diagnostic de situation	Analyse argumentée des besoins et des ressources d'une population
Éducation pour la santé	Aider une personne ou un groupe à acquérir des compétences pour sa santé
ETP	Éducation thérapeutique du patient (soin, BC1)
FALC	Facile à lire et à comprendre
Gantt	Diagramme qui place les tâches dans le temps
HACCP	Méthode d'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques
IDDSI	Cadre international des textures modifiées (niveaux 0 à 7)
Incidence	Nouveaux cas pendant une période
Indicateur	Donnée qui mesure l'atteinte d'un objectif
IREPS	Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé
Littératie en santé	Capacité à trouver, comprendre et utiliser l'information de santé
Odds ratio	Mesure d'association des études cas-témoins
PAT	Projet alimentaire territorial
PNNS 5	Programme national nutrition santé 2026-2030
Prévalence	Proportion de cas à un moment donné
Prévention primaire, secondaire, tertiaire	Avant la maladie, au début, une fois installée
Promotion de la santé	Donner aux populations les moyens d'agir sur leur santé (Ottawa, 1986)
RGPD	Règlement général sur la protection des données (2016/679)
Risque relatif	Mesure d'association des études de cohorte
SMART	Spécifique, mesurable, acceptable, réaliste, temporellement défini
SNANC	Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat 2025-2030
Tableau de bord	Tableau qui rassemble les indicateurs, les cibles et les résultats
Teach-back	Faire redire pour vérifier la compréhension
Universalisme proportionné	Agir pour tous, plus intensément pour ceux qui en ont le plus besoin

Terme	Définition courte
Veille	Surveillance organisée de l'information utile au métier